

# ارتباطات سلامت

تهیه و ترتیب: دیپارتمنت مطالعه‌ی ارتباطات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## فهرست مطالب

### مقدمه

مفاهیم کلیدی از منظر اسلامی

### درس نخست

#### کلیات ارتباطات سلامت

- مسائل مهم و حیاتی در عرصه ارتباطات سلامت
- اهمیت آموزش ارتباطات سلامت برای محصلان حوزه ارتباطات
- دنیای اشتغال (تحقیقات و روزنامه‌نگاری تخصصی)
- افزایش حساسیت محصلان به مسائل سلامت اجتماعی
- توانمندسازی در درک و تحلیل کلیشه‌های رسانه‌ای
- حمایت نظام سلامت کشور

### درس دوم

#### تعریف ارتباطات سلامت و ماهیت ارتباط

- تعریف ارتباطات سلامت: جستجو، پردازش و هم‌رسانی اطلاعات مرتبط به سلامت
- جستجوی معلومات سلامت
- پردازش معلومات (تأثیر بستر فرهنگی-اجتماعی)
- هم‌رسانی معلومات (رسانه‌های اصلی و جمعی)
- ارتباطات عامل اساسی سلامت
- رابطه مستقیم و تعاملی ارتباط با سلامت
- ماهیت شفاف‌بخش ارتباط

- نقش تشویقی ارتباطات سلامت
- ماهیت مبادله‌ای ارتباط
  - ارتباط به عنوان بستر پیام و حامل معنی
  - مدل مبادله‌ای ارتباطات (شراکت فرستنده و گیرنده در شکل‌دهی معنا)
  - ابعاد ارتباط مبادله‌ای: معناسازی همکارانه، سطوح چندگانه معناسازی، اهمیت زمینه و فرهنگ

## درس سوم

### نگاه‌های مراقبت از سلامت

- نگاه بدنی-طبی به سلامت (Biomedical model)
  - سلامت به عنوان امر فیزیکی
  - انتقادات وارد بر این شیوه
- نگاه بدنی-روانی-اجتماعی به سلامت (Biopsychosocial model)
  - سلامت تحت تأثیر عوامل جسمی، روانی و اجتماعی
  - اهمیت حمایت اجتماعی
- نگاه فرهنگی-اجتماعی به سلامت
  - سلامت به عنوان مجموعه‌ای از تأثیرات فردی، اجتماعی و فرهنگی
  - عوامل مرتبط با بعد اجتماعی (سرمایه، فقر، کلیشه‌ها)
  - بعد فرهنگی (ارزش‌ها و مناسک)
- نگاه کارآمد: ترکیب سه شیوه در مواقع ضروری

## درس چهارم

### مسائل تأثیرگذار بر کیفیت و کمیت ارتباطات سلامت

#### • خدمات وقایه‌ای

- "وقایه، بهتر از درمان است"
- مدیریت زمان و اولویت‌بندی فعالیت‌ها (پنجره جوهری)
- نقش رسانه‌های جمعی در ترویج وقایه
- نیاز به زیرساخت قوی و درآمد مناسب

#### • کیفیت خدمات

- توازن میان مصرف و خدمات مراقبتی-درمانی
- وضعیت کیفیت خدمات در آمریکا و افغانستان
- طب سنتی در خاورمیانه: داروهای گیاهی و ادویه
- نظریات مردم در مورد طب سنتی و مدرن
- تغییر در کیفیت جمعیت
- تأثیر مهاجرت و جابجایی داخلی بر دیدگاه‌های سلامت
- میزان دسترسی به خدمات مراقبت از سلامت و سواد سلامت

#### • توانمندشدن بیمار

- نقش رسانه‌های جمعی و گسترش آموزش همگانی
- تغییر نقش متخصصان سلامت به مشاور
- استفاده از فناوری
- تحول در جستجو، پردازش و هم‌رسانی اطلاعات سلامت (شبکه‌های اجتماعی، تله‌مدیسین)

- نقش فناوری در توانمندسازی بیماران

## درس پنجم

### تفاوت میزان اقتدار در گفت‌وگوی بیمار-مراقب

- تفاوت اقتدار: ناشی از دانش، مهارت، موقعیت اجتماعی-اقتصادی
- دانش و قدرت: تأثیر میزان دانش بر نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها
- گویندگان: شنوندگان: سهم بیشتر مراقبان در گفت‌وگو
- مشارکت بیمار در درمان: افزایش رضایت و پایبندی به درمان با مشارکت بیمار
- پرسش و هدایت: ابزار ارتباطی برای باز کردن فضا و بهبود تشخیص
- پرسش‌های باز و بسته
- استفاده هماهنگ از پرسش و هدایت
- تحریف: تغییر، دستکاری یا انتقال نادقیق پیام‌ها
- انواع تحریف (زبانی، ادراکی، عاطفی، آگاهانه، رسانه‌ای)
- علل بروز تحریف و پیامدهای آن
- راهکارهای کاهش تحریف
- نگاه بالا به پایین در ارتباطات سلامت
- تعریف و ویژگی‌ها (مراقب در جایگاه قدرت)
- دلایل شکل‌گیری و پیامدهای منفی
- راه‌حل و رویکرد جایگزین (رابطه مشارکتی)

## درس ششم

### ارتباط همکارانه و تکنیک‌های ارتباطی

- مدل ارتباط همکارانه: تعامل دوطرفه، احترام متقابل و تصمیم‌گیری مشترک

- ویژگی‌ها، مزایا و اجزای اصلی (شنیدن فعال، پرسش باز، بازخورد دوسویه، تصمیم‌گیری مشترک)
- **دیالوگ:** کنش‌گری برای معناسازی مشترک
- **تکنیک‌های کلامی در ارتباطات سلامت**
  - تعریف و اهداف (افزایش درک، اعتماد، تسهیل تصمیم‌گیری)
  - مهم‌ترین تکنیک‌ها (سادگی زبان، تکرار، پرسش و پاسخ فعال، بازتابی، استعاره، تقویت مثبت، روایت، زبان همدلانه، ساختاردهی پیام، ارائه انتخاب)
  - کاربرد در موقعیت‌های مختلف
  - **نمونه‌ای از سه قصه:** درد جسمی، قصه شخصی، قصه احساسی
  - **تکنیک‌های غیرکلامی:**
    - مفهوم و تکنیک‌های اصلی (تماس چشمی، حالات چهره، حرکات بدن، لحن صدا، فاصله فیزیکی)
    - راهکارهای عملی برای تقویت ارتباط غیرکلامی
    - نقش تکنیک‌های غیرکلامی در موقعیت‌های خاص
    - پیامدهای منفی ارتباط غیرکلامی ضعیف
- **مصاحبه روشنگرانه (Informative Interview) :**
  - تعریف جامع و ویژگی‌های کلیدی (اطلاع‌رسانی دقیق، بی‌طرفی، ساده‌سازی)
  - اهداف (ارتقاء سواد سلامت، اصلاح باورها، کاهش اضطراب)
  - مثال‌ها و نکات کلیدی برای اجرای مؤثر
  - **تعریف "وضعیتی به نام بیماری":**
    - جنبه‌های ارتباطی (تجربه فردی-اجتماعی، نقش رسانه‌ها، تأثیر بر هویت، زبان بیماری، برخورد نظام سلامت)

- "دنیای زندگی، دنیای تداوی:"

- تداوی به عنوان روند انسانی، اجتماعی و ارتباطی
- نقش ارتباط در پیوند زندگی و تداوی
- دنیای زندگی به عنوان منبع معنا
- تداوی فراتر از درمان جسم
- احساسات و شواهد: یک بررسی جامع:
- تعریف احساسات و شواهد در ارتباطات سلامت
- چالش‌ها در ترکیب احساسات و شواهد
- راهبردهای کاربردی برای ترکیب احساسات و شواهد

### درس هفتم

#### موضوعات مرتبط اجتماعی-فرهنگی سلامت

- درد؛ حواشی درد

- تعریف درد از منظر ارتباطات سلامت
- حواشی درد: ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی
- نقش ارتباطات سلامت در مدیریت و درک درد
- چالش‌های ارتباطی پیرامون درد

- "بیماری، هویت شخصی"

- تعریف جامع و محورهای کلیدی (روایت بیماری، بازتعریف خود، برچسب‌گذاری اجتماعی، هویت بیمار در نظام درمانی، نقش خانواده و جامعه)
- واکنش هویتی بیمار:
- تعریف مفهومی و ابعاد مختلف (درک از خود، ادراک اجتماعی، بازتعریف هویت، تعامل با نظام سلامت)

- نقش ارتباطات سلامت در مدیریت واکنش هویتی بیمار
- چهار مرحله واکنش هویتی بیمار (شوک و انکار، درگیری هویتی، سازش هویتی، بازسازی هویت)

### درس هشتم

نتیجه گیری از هشت سمستر و امتحان ۲۰٪

### درس نهم

تعریف بیماری و سلامتی از نگاه فرهنگ‌های مختلف

- تفاوت مفهوم بیماری و سلامتی در فرهنگ‌های مختلف
- توانمندی فرهنگی و شیوه‌های جستجو، دریافت و هم‌رسانی معلومات سلامت

### درس دهم

مددکاری اجتماعی

- تعریف مددکاری اجتماعی
- اهداف مددکاری اجتماعی (ارتقاء رفاه، توانمندسازی، مشارکت)
- اصول و ارزش‌ها (حرمت انسانی، حق بهره‌مندی برابر، مسئولیت فردی و اجتماعی)
- سطوح فعالیت (خرد، میانه، کلان)

### درس یازدهم

کار عملی

### درس دوازدهم

رابطه سلامت و فناوری

- فناوری اطلاعات سلامت (Health IT)
- موضوع الکترونیکی سلامت (EHRs)

- سیستم‌های تصمیم یار طبی (CDSS)
- پلتفرم‌های تله‌مدیسین
- سلامت همراه (mHealth)
- اپلیکیشن‌ها و پوشیدنی‌های دیجیتال
- هوش مصنوعی در سلامت (AI in Healthcare)
- تحلیل تصاویر طبی، پیش‌بینی بیماری‌ها، ربات‌های جراحی
- چاپ سه‌بعدی (ساخت اندام مصنوعی، مدل‌های آناتومیک، داروهای سفارشی)
- اینترنت اشیاء داکتری (IoMT)
- دستگاه‌های متصل برای جمع‌آوری داده‌های زیستی
- چالش‌ها و نگرانی‌ها (حریم خصوصی، هزینه، دسترسی نابرابر)

### درس سیزدهم

#### مدیریت کلان سلامت عمومی و نقش ارتباطات سلامت

- مدیریت کلان سلامت عمومی و ضرورت ارتباطات
- بازاریابی اجتماعی در سلامت عمومی (شناخت مخاطب، پیام متناسب، کانال‌های مؤثر)
- نقش روابط عمومی سلامت (سخنگویان رسمی، مدیریت بحران، تعامل با رسانه‌ها)
- چالش‌ها و راهکارها

### درس چهاردهم

#### تصویر سلامت در رسانه‌ها

- رسانه به عنوان منبع آگاهی سلامت
- بازنمایی سلامت در رسانه‌های سنتی (تلویزیون، رادیو، مطبوعات)
- سلامت در رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی (پلتفرم‌ها، اخبار جعلی)

- تأثیر رسانه‌ها بر رفتار و نگرش سلامت

- چالش‌ها و فرصت‌ها

- اهمیت سواد رسانه‌ای سلامت

## درس پانزدهم

### مبارزه برای سلامت عمومی

- مفهوم مبارزه در سلامت عمومی (رفع موانع، پیشبرد آگاهی، تأثیر بر سیاست‌گذاری)

- شیوه‌های مبارزه (کمپین‌های اجتماعی، مطالبه‌گری، تحرکات مردمی، مبارزه علمی)

- نقش ارتباطات سلامت در این مبارزه

## درس شانزدهم

### جمع‌بندی

فهرست منابع

## مقدمه

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

سلامت به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی انسان، همواره در مرکز توجه مکاتب فکری، اجتماعی و دینی قرار داشته است. در جهان اسلام، سلامت نه تنها یک بعد جسمی، بلکه مقوله‌ای چندبعدی شامل سلامت روان، روح، و اجتماع دانسته شده که در پرتو هدایت الهی و تعالیم نبوی معنا می‌یابد. قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، رهنمودهای فراوانی درباره رعایت اصول سلامت و شیوه‌های ارتباطی در جهت پیشگیری، درمان و حفظ سلامت فرد و جامعه ارائه کرده‌اند.

قرآن کریم در سوره بقره آیه ۱۹۵ می‌فرماید: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»؛ «و خود را با دست خود به هلاکت می‌فکنید». این آیه الهی نوعی هشدار در برابر بی‌توجهی به سلامت است که می‌توان آن را بنیان یک اصل در سیاست‌گذاری‌های سلامت عمومی دانست. همچنین در سوره شعراء آیه ۸۰ آمده است: «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ»؛ «و هنگامی که بیمار شوم، او (خداوند) مرا شفا می‌دهد»، که تأکید بر نقش توکل و امید در پروسه شفا دارد، اما در عین حال، بهره‌گیری از اسباب و ابزارهای سلامت را نیز لازم می‌داند.

در کنار تعالیم قرآنی، احادیث نبوی نیز به صراحت بر حفظ سلامت بدن و جامعه تأکید دارند. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ» (صحیح مسلم)؛ «مؤمن قوی بهتر و محبوب‌تر نزد خداوند است از مؤمن ضعیف». این حدیث گواه آن است که

سلامت جسم و روان از مؤلفه‌های اساسی رشد ایمانی و کارآمدی اجتماعی در دیدگاه اسلامی محسوب می‌شود.

در این میان، ارتباطات سلامت به عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای، نقشی تعیین‌کننده در انتقال مؤثر اطلاعات طبی، ترویج رفتارهای سالم، و ارتقاء آگاهی عمومی دارد. از نگاه اسلامی، ارتباط میان داکتر و بیمار، نهادهای درمانی و مردم، و حتی رسانه‌ها و جامعه باید بر اساس صداقت، امانت‌داری، شفقت و نیت صالحانه استوار باشد. قرآن می‌فرماید: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» (بقره: ۸۳)؛ «و با مردم به نیکویی سخن بگویید»، که می‌تواند اساس برای اخلاق ارتباطی در حوزه سلامت تلقی گردد.

بنابراین، تحلیل «ارتباطات سلامت» از منظر قرآنی و نبوی نه تنها به درک بهتر ماهیت این نوع ارتباطات کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگوی معنوی و فرهنگی مؤثری برای توسعه نظام‌های سلامت در جوامع اسلامی ارائه دهد.

به صورت اختصار:

#### ۱. سلامت به عنوان امانت الهی

در قرآن کریم، جان و بدن انسان امانتی از سوی خداوند تلقی شده است. آیه «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» (اسراء: ۳۶) نشان می‌دهد که انسان در قبال سلامت جسم و روان خود مسئول است. از این منظر، هرگونه بی‌توجهی به سلامت (مثل پنهان کردن بیماری، مصرف مواد زیان‌آور، یا نشر اطلاعات غلط) مصداق خیانت به امانت است.

## ۲. نقش رسانه‌های اسلامی در ارتباطات سلامت

رسانه‌ها می‌توانند ابزار مهمی در ترویج سبک زندگی اسلامی - سالم باشند. به عنوان مثال، اشاعه فرهنگ تغذیه حلال، ورزش، و رعایت بهداشت فردی از طریق رسانه‌های جمعی با روح تعالیم اسلامی سازگار است. از منظر ارتباطات سلامت، رسانه نباید تنها به اطلاع‌رسانی اکتفا کند، بلکه باید با رویکرد اقناعی و تربیتی، اصلاح سبک زندگی را دنبال کند.

## ۳. اخلاق در ارتباطات سلامت

رعایت رازداری، احترام به بیمار، پرهیز از تحقیر و تبعیض، و برخورد مشفقانه از مهم‌ترین اصول اخلاقی در این نوع ارتباط است. حدیث نبوی: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ» (کسی که رحم نکند، به او رحم نخواهد شد) می‌تواند اساس «رحمت در تعاملات درمانی» باشد.

## ۴. سلامت روان و نقش ارتباطات اسلامی

اضطراب، ناامیدی، و افسردگی از مسائل رایج روانی‌اند که در جوامع امروزی افزایش یافته‌اند. قرآن با پیام‌هایی چون: «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» (رعد: ۲۸)، به نقش آرام‌بخش معنویت و یاد خدا در سلامت روان اشاره می‌کند.

ارتباط سالم با خداوند، خانواده و جامعه می‌تواند درمانی برای بسیاری از مشکلات روانی باشد.

## ۵. اصل مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سلامت

در آیات متعددی به همکاری و همیاری میان مؤمنان تأکید شده است. مانند: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» (مائده: ۲).

این اصل حتی می‌تواند مبنای مشارکت مردم در برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت و کمپین‌های واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری‌ها باشد.

## ۶. پیشگیری، اصل طلایی سلامت از منظر قرآن و سنت

پیغمبر اکرم (ص) فرموده‌است: «الوقایه خیر من العلاج» (پیشگیری بهتر از درمان است)، این موضوع در حدیث مشهور آمده است، و همچنان با آموزه‌های پیشگیرانه قرآن کاملاً سازگار و بیان شده است. مانند آداب صحی، تغذیه سالم، و توصیه به پاکی و نظافت.

## مقدمه مترجم

این جزوه حاصل برداشت و ترجمه آزاد مترجم است. در عین حال، مترجم به هدف آسانی در درک متن برای محصلان، مثال‌ها و نکاتی را از جامعه افغانستان هم اضافه کرده است. معنی این حرف این است که گاهی یا اغلب مثال‌های جامعه‌ی نویسنده (کشورهای دور) با مثال‌های بومی افغانستان تبدیل شده اند؛ مگر، تلاش مترجم این بوده است که با در نظر داشت تفاوت‌های فرهنگی- اجتماعی این جوامع و دگربودگی مفهوم سلامت در این دو بخش جهان، تا اندازه‌ای سلامت و همسانی مثال‌ها را مراعات کند.

حاشیه‌نویسی (یادداشت برداری)، بخشی دیگر از این جزوه است. مطالب یادداشت برداری با کمک محصلان تهیه شده‌اند. این‌ها مطالبی‌اند که محصلان به بهانه کارخانگی سرِ صنفی جمع‌آوری کرده‌اند. اغلب جواب‌گویان، از گروه‌های سنی مشخص بوده‌اند و طبقات اقتصادی و میزان سواد اکادمیک آن نیز شبیه نبوده است. در کنار این معلومات، که اغلب ممکن است قابل تعمیم به تمام افغان‌ها نباشند، از تحقیقات علمی انجام شده در افغانستان نیز استفاده شده است.

دیدگاه شرقی‌ها در مورد امور سلامت و مفهوم سلامت تفاوت‌هایی دارد. از طرفی، دیدگاه غالب در جامعه علمی جهان و از جمله در کتاب مورد ترجمه، بر اساس دیدگاه غربیان راجع به سلامت و مفهوم سلامتی استوار است. این تفاوت، برای محصلان افغانستان اندکی قابل درک نیست. به همین دلیل، محصلان تلاش کردند در کنار درک مفهوم غربی مساله، از شرقیان نیز پرسش‌هایی داشته باشند. به عنوان نمونه، در کتاب، سلامت را از نگاه تعریف سازمان جهانی سلامتی بحث کرده است.

این تعریف، با آن که از مدت شش دهه به عنوان تعریف ماندگار برای سلامتی تلقی شده است، مگر،  
خاستگاه غربی دارد. به همین دلیل، محصلان – که از آنان امتنان دارم – مرا در تبیین و توصیف  
سلامتی از دیدگاه بومی یاری کردند.

«جان جوری، پادشاهی است»

(مردی روستانشین (دهاتی) افغان)

در این درس خواهید آموخت:

- مسایل مهم و حیاتی در عرصه ارتباطات سلامت چه اند؟
- چرا محصلان حوزه مطالعه‌ی ارتباطات، ارتباطات سلامت را بیاموزند؟

ارتباطات سلامت، عرصه میان‌رشته‌ای است. رشته‌های مرتبط به سلامت (طبابت، داروسازی، خدمات مراقبت درمانی مانند پرستاری) و عرصه‌های تحقیقاتی - مطالعاتی مرتبط به ارتباطات انسانی (چه ارتباطات با رسانه‌های اصلی و چه ارتباط از ورای رسانه‌های جمعی) در بحث ارتباطات سلامت سر رشته‌هایی دارند. به عنوان نمونه، چگونگی رابطه مراقب سلامت (شما و پدر پیر تان) مرتبط به سازوکارهای ارتباطی میان‌فردی است. از طرفی، چون ارتباط به هدف ارائه خدمات مراقبتی میان شما و پدر تان اجرا می‌شود، لازم است که ارتباط‌گر (شما) ماهیت مراقبت را نیز بدانید. برای درک ماهیت خدمات مراقبت سلامتی، حتی اگر سازوکارهای ارتباط میان‌فردی را به صورت تخصصی هم بدانید، مجبورید پای صحبت و رهنمایی متخصصان بخش سلامت بنشینید. در این صورت، طبق تعریف ارتباطات سلامت، ارتباط‌گری مفید و موفق کسی است که از هر دو عرصه ارتباطات و بخش‌های سلامت سر رشته‌هایی داشته باشد.

هدف ارائه این درس برای محصلان عرصه مطالعات ارتباطات آن است که با گذراندن این درس، فرد، اطلاعات و دانش نظری کافی در مورد چگونگی برقراری ارتباط به هدف ارائه خدمات سلامتی را به دست می‌آورند. چه این که از محصلان بخش ارتباطات، انتظار می‌رود که به عنوان متخصصان این بخش، در کنار این که خود ارتباط‌گرانی مفید برای جامعه و خود باشند، باید گسست‌های ارتباطی را میان افراد جامعه هم به صورت علمی دریافت و درک (توصیف و تبیین) کنند.

یکی از گسست‌های ارتباطی در عرصه ارتباطات سلامت رخ می‌دهد. چنانچه طبق آمار، در کشورهای غربی، سالانه .... به سبب گسست ارتباطی میان داکتران و بیماران به اقتصاد این کشور ها ضربه وارد می‌شود.

اهمیت درس ارتباطات سلامت برای محصلان ارتباطات از چندین منظر قابل بحث است:

منظر نخست، دنیای اشتغال: فراگیری این درس عرصه‌ای جدید تحقیقاتی- اجرایی در کوله‌بار دانشی محصلان اضافه می‌کند. بنابراین، انتظار این است که محصلان در آینده شغلی شان، در بخش تحقیقات مرتبط به امور سلامتی سر رشته‌هایی داشته باشند. درضمن، ممکن است فارغانی از این رشته در عرصه‌های تخصصی رورنامه‌نگاری کار کنند. از آن جایی که هنوز در افغانستان روزنامه‌نگاری به صورت تخصصی در نیامده است، فراگیرندگان این درس می‌توانند فرصت‌های شغلی در این عرصه داشته باشند.

منظر دوم، افزایش میزان حساسیت محصلان به مسایل مرتبط به سلامت در عرصه اجتماعی: ارتباطات سلامت، محصلان را به عنوان ارتباط‌گرانی حساس به مساله حیاتی سلامت و ارتباط سالم به بار می‌آورد. به گونه نمونه، توقع ما این است که محصلان بعد از آموزش مدل‌ها و نظریات مرتبط به ارتباطات سلامت، با همسالان ارتباط مشفقانه‌تر، با بزرگتران، رابطه محترمانه‌تر و انسانی‌تر و با کوچکتران ارتباط محتاطانه- بیشتر مراقبتی داشته باشند. ارتباطات سلامت، مهارت ارتباطات میان‌فردی را می‌افزاید. طبق آمار آخری، نزدیک به چهل درصد جمعیت کشور، صرف سواد نوشتن و خواندن را دارند. معنی این حرف آن است که محصلان این درس و مراقبان سلامتی با جمعیتی

سروکار دارند که حداقل شصت درصد آنان معلومات مرتبط به سلامتی شان را از طریق ارتباط میان فردی غیر نوشتاری جستجو، پردازش و هم‌رسانی می‌کنند. به عبارتی، سواد سلامتی در نزد آنان خیلی پایین است. از طرفی این آمار احتمال بالای عدم استفاده درست از خدمات مراقبت و درمان را نیز تایید می‌کند. هنوز آماری از مشکلات سلامتی به اثر استفاده نادرست دارو در افغانستان نداریم، ولی همین نکته در کشورهای پیشرفته مصداق دارد. چنانچه اگر سواد سلامتی افراد را در آمریکا بیافزایند، سالانه ۱۰۶ میلیون دالر از هزینه سلامتی پس‌انداز خواهد شد (ویرلون و تورجیلیو و دوبونو، ۲۰۰۷).

اهمیت دیگر درس در این است که محصلان را در درک و تحلیل کلیشه‌های رسانه‌ای در رابطه با سلامتی توانمند می‌سازد: به عنوان نمونه، هر از گاهی تبلیغاتی در مورد کمربند لاغری از تلویزیون‌ها می‌شنویم. ادعای این تبلیغات این است که این کمربندها هدیه‌ی لاغری را به میان می‌آورد. در حالی که به عکس، تحقیقات علمی نشان داده اند که چاقی را از راه‌هایی چون ورزش و اصلاح رژیم غذایی می‌توان اصلاح کرد. هرگاه محصلان معلوماتی شبیه این مورد را بیابند، نوعی اعتماد به نفس برخاسته از اطلاعات کسب می‌کنند. بنابراین، از اهمیت‌های دیگر این درس برای محصلان این است که میزان اعتماد به نفس شان را در مراقبت از سلامت خود و کمک ارتباطی به سایر افراد در راستای نگهداشت سلامتی جامعه افزایش بدهند. توانمندسازی محصلان در این عرصه به معنی توان افزایش میزان توان مقابله آنان با مشکلات مرتبط به سلامت فردی و جامعه نیز هست. به همین ترتیب، یکی از اهمیت این درس ایجاد توان مقابله با چالش‌های فراروی سلامت جامعه، برقراری ارتباطات

سالم به هدف نگهداشت سلامت روانی و جسمی و در نتیجه عام‌شدن و گسترده‌گی موثر ارتباطات مفید سلامت می‌باشد.

منظرسوم، حمایت نظام سلامت کشور: تحقیقات نشان داده اند که بدون رعایت قواعد ارتباطات سلامت از سوی داکتران، پرستاران، خبرنگاران و ارتباط‌گران دیگر (از جمله اعضای خانواده) نظام سلامت در سطح کشور دچار مشکل بیشتری خواهد شد. به عکس، نظام موفق مراقبت آن است که در آن بیمار با توانمندی ارتباطی شان مشکلات مرتبط را با مراقب شریک بتواند.

این درس طی چهارده جلسه درسی و دو جلسه امتحانی (آزمونی) برگزار می‌گردد. درس نخست به معرفی کلیات درس ارتباطات سلامت اختصاص دارد که هم‌اکنون مشغول مطالعه شرح همین درس هستید.

درس دوم، در مورد تعریف ارتباطات سلامت است. درضمن، بر تعریف ارتباط تمرکز دارد که از آن میان نوعی ارتباط موسوم با «ارتباط انتقالی-تفسیری» بیشتر مورد بحث است. در ضمن، چگونگی برقراری ارتباط سلامت و بسترهای الزامی آن از بخش‌های درس است. به عنوان نمونه، در این درس خواهیم گفت که چگونه ارتباطی با ماهیت انتقالی‌بودن و تفسیری مشربی‌اش، مستلزم همکاری فرستنده و گیرنده در ایجاد معنا، لایه‌های معنایی و همچنان موجودیت فرهنگ و زبان است؟

درس سوم، به مسایل مهم برای عرصه ارتباطات سلامت است. از جمله، مسایل تاثیرگذار بر کیفیت و حتی کمیت موارد ارتباطی ارتباطات سلامت، جمعیت کشور، میزان و کیفیت سلامتی عمومی در جهان و افغانستان و مداخله فناوری در این مسایل است. در این درس دیدی کلی از مسیرهای

تأثیرگذاری مفاهیم گفته بر شیوه‌های برقراری ارتباطات سلامت ارائه خواهد شد. در ضمن، در همین درس شیوه‌های جهانی و شناخته‌ی درمان بیمار بحث شده و گفته می‌شود که هرکدام از این سازوکارها به اساس کدام دیدگاه به سلامتی، بدن، روان (روح) به میان آمده اند.

درس چهارم به مراقبت از سلامت و نمونه‌های مراقبت از سلامت می‌پردازد. در این درس به این نکته می‌پردازیم که آیا بهتر است که فرد قبل از بیماری، در صدد وقایه از سلامتی اش باشد، یا این که منتظر بماند تا بیماری وی را از پا در بیاورد و سپس به درمان‌گر (معالج) مراجعه کند. البته در این باره هم صحبت می‌کنیم که چرا رویکرد مراقبتی در کشورهایی مانند افغانستان جوابگو نیست، ولی در جاپان و آمریکا کارآمد است.

درس پنجم ارتباطات بیمار و مراقب را مطالعه می‌کند. در همین درس موضوعات مهم و تأثیرگذار بر پروسه ارتباط میان فردی بیمار و مراقب شمرده می‌شود؛ از جمله، روابط اقتداری به نفع مراقب. یکی از منابعی که رابطه میان فردی بیمار - مراقب را به سمت ارتباط عمودی می‌برد، دانش تکنیکی متخصص نسبت به بیماری و هم‌چنان میزان منزلت اجتماعی موقعیت مراقبت در یک جامعه است. در همین درس خواهیم گفت که به هر اندازه کیفیت دانش و درجه منزلت مراقب نسبت به بیمار بالاتر باشد، ارتباط شان نا افقی می‌گردد. درعین زمان، به شیوه‌های نامتوازن‌سازی ارتباط بیمار - مراقب می‌پردازیم؛ از جمله، گفته خواهد شد که چگونه سازوکار نمایندگی ناخواسته<sup>۱</sup>، انحراف موضوع گفتگو و ارتباط<sup>۲</sup> باعث می‌گردند ارتباط افقی نماند. دلایل تغییر رابطه از افقی به عمودی نیز بحث

---

<sup>۱</sup> - Patronization

<sup>۲</sup> - Blocking

می‌شود. در نهایت این درس تلاش دارد به سوالاتی از این دست جواب بدهد: در ارتباط میان فردی بیمار- مراقب، چه کسی بیشتر صحبت می‌کند؟ و چه کسانی در رابطه به درمان و حتی بیماری تصمیم می‌گیرند؟ از طرفی این درس به این هدف ارائه می‌شود که مهارت‌های ارتباط‌گیری با بیمار را نیز به مراقب بدهد. این مامول با بحثی زیر عناوین «ارتباط همکارانه»<sup>۲</sup>، «دیالوگ»، «مصاحبه انگیزشی» برآورده خواهد شد.

درس ششم، دنیا را از نگاه بیمار مطالعه می‌کند. در این درس محصلان می‌دانند که کدام شیوه‌های ارتباط‌گیری با بیمار حسی خوب و خوشی می‌دهد و کدام‌ها از نگاه بیماران نامقبول اند. محصلان برای درک این موضوع اول باید مسایلی مرتبط به وضعیتی به نام بیماری بدانند و سپس به این نکته برسند که هویتی به نام «بیمار» چه وضعیتی را به وی می‌دهد. به همین دلیل، در این درس، هویت بیمار از نگاه مراقبت و خود بیمار بحث می‌شود. در بخشی از درس به این نکته پرداخته می‌شود که چگونه روابط قدرت و دانش نوعی اقتدار به مراقب داده و به این صورت بیمار را در وضعیت ناتوانمندی قرار می‌دهد. مصادق این وضعیت با شرح تعریف بیماری از نگاه علوم طبی و همچنان از نگاه خود بیمار ارائه می‌شود. در نهایت، بخشی را به رهنمایی عملی ارتباط‌گیری به بیماران اختصاص داده اند که محصلان با اتکاء به آن‌ها، ارتباط‌گیری شان را در مسیر انسانی و توانمندساز داشته باشند.

درس هفتم به موضوعات مرتبط اجتماعی- فرهنگی سلامت می‌پردازد. در این درس محصلان می‌آموزند که چگونه شاخص‌های مرتبط به هویت اجتماعی- جمعیت‌شناختی (جنسیت، نژاد، زبان،

---

<sup>۲</sup>- collaborative communication

فرهنگ و سن و شغل) بر معنی سلامت و ارتباط سلامت تاثیر می گذارند. درضمن، به این نکته اشاره

می شود که چگونه توانایی و دانایی بیمار در تغییر ماهیت و شیوه ارتباط گیری مراقب اثرگذارند؟

درس هشتم به امتحان میان سمستر اختصاص دارد که طی از هفت درس قبلی به صورت نظری

امتحان گرفته می شود. هدف این امتحان این است که محصلان میزان آموخته های شان را آزمایش

کنند و درعین زمان متوجه شوند که آیا مطالب مورد را پرسش را به چه اندازه و کیفیت درست

فهمیده اند. درضمن، با نوعیت پرسش و شیوه های آزمون دهی این مضمون آشنایی یابند.

درس نهم، به تعریف بیماری و سلامتی از نگاه فرهنگ های مختلف می پردازد. به همین خاطر، با

اشاره به تحقیقات انجام شده در عرصه ارتباطات سلامت در فرهنگ های مختلف این درس تلاش

دارد که این گزاره را ثابت کند: سلامت و بیماری حالات و وضعیت بشری است که به صورت موقتی

و یا زمانی طولانی انسان را مبتلا می کند. در عین زمان، مفهوم بیماری و سلامتی در فرهنگ های

مختلف متفاوت است. یکی از مباحث دیگر این درس، توانمندی فرهنگی است تا بدانیم که میان

توانمندی فرهنگی و شیوه های جستجو، دریافت و هم رسانی معلومات مرتبط به سلامت چه

تفاوت هایی هست.

درس دهم به موضوع مددکاری اجتماعی ربط دارد. هدف این درس این است که محصلانی که درس

ارتباطات سلامت را می دانند، چگونگی برقرار ارتباط موثر و سالم را با بیماران، به عنوان اعضای

جامعه، بیاموزند و یا حداقل ارتباط همکارانه داشته باشند. ممکن است این بیماران، حتماً بیمار در

شفاخانه ها، نباشد، بلکه همین که محصلان بتوانند ارتباط مفید با دوستان و اعضای خانواده ی نیازمند

و بیمار خود داشته باشند، درست است. البته این نکته مهم است که مفیدیت ارتباط با بیماران، مستلزم تداوم ارتباط نیز است؛ از طرفی، این بیماران می‌توانند از طیف‌های متفاوت اجتماعی، شغلی و یا سنی باشد. به عنوان نمونه، در این درس به محصلان مهارت‌های ارتباط‌گیری با کهنسالان و مخاطرات ارتباط‌گیری با آنان نیز آموزش داده می‌شود. در عین زمان به آنان نشان داده می‌شود که چگونه آموزش موثر به عنوان یکی از بخش‌های مهم زندگی باکیفیت است.

درس یازدهم یک کار عملی به راه انداخته می‌شود، در این درس کوشش می‌شود، عملاً محصلان را از مفیدیت ارتباط سالم مریض و یا در کل مردم با جامعه طبی آگاه سازیم.

رابطه سلامت و فناوری عنوان مبحث عمده‌ای درس دوازدهم است. در این درس مساله این است که چگونه اینترنت در خدمت سلامتی قرار گرفته است؛ از جمله، محصلان مطالبی را در مورد خدمات آنلاین ارائه خدمات سلامتی را خواهند خواند. در ضمن، بحث خدمت موبایل به سلامت بخشی از این درس است. در نهایت، با نگاهی انتقادی به اینترنت در خدمت سلامتی سوالاتی مطرح می‌شود؛ از جمله، آیا خدمات آنلاین سلامت برای همه افراد دنیا با عین کیفیت و قیمت است؟ آیا شکاف اطلاعاتی و توان استفاده از فناوری موانعی بالقوه استفاده همگان از خدمات مراقبت از سلامت نیستند؟

درس سیزدهم در مورد مدیریت امور کلان سلامت عمومی است و نقش ارتباطات سلامت در سطح کلان آن است. این مباحث را در عرصه‌های بازاریابی، روابط عامه پی می‌گیریم. در این درس گفته می‌شود که چگونه ارتباط دوطرفه میان بیمار و نهادهای ارائه‌کننده خدمات مراقبت از سلامت از

گسست‌های ارتباطی تاثیر می‌گیرند؟ درعین زمان گفته می‌شود که چگونه از شبکه‌های اجتماعی برای جستجو، پردازش و هم‌رسانی معلومات مرتبط به سلامتی در سطح کلان بهره ببریم.

درس چهاردهم در مورد تصویر سلامت در رسانه‌ها بحث می‌کند. هدف از این درس آن است که محصلان بدانند که تا حدی مفاهیم سلامت و بیماری ساخته شده رسانه‌ای اند. در این درس بحثی مرتبط به سبک زندگی موثر برای سلامتی نیز اختصاص داده شده است؛ زیرا نویسنده معتقد است که قسمتی از بیماری چاقی در آمریکا به بدخوری برمی‌گردد که این بدخوری به نوبت خود متأثر از سبک‌های برگرفته از تلویزیون است. درس پانزدهم به مبارزه برای سلامت عمومی اختصاص داده شده است. هدف از ارائه این درس آن است که محصلان شیوه‌های مبارزه برای سلامت عمومی را بیاموزند. درس شانزدهم به جمع‌بندی اختصاص داده شده است.

## درس دوم

در این درس خواهید آموخت:

- تعریف ارتباطات سلامت
- موضوعات اساسی برای ارتباطات سلامت
- ارتباط «انتقالی- تفسیری» و رابطه آن با ارتباطات سلامت

## تعریف ارتباطات سلامت

از ارتباطات سلامت، تعاریفی شده است؛ از جمله، ارتباطات سلامت را پروسه «جستجو، پردازش و هم‌رسانی معلومات مرتبط به سلامت» (دوپری، ۲۰۱۷: ۹).

منظور از جستجوی معلومات سلامتی این است که بیمار یا فردی سالم از کدام منابع معلومات را به دست می‌آورند. آیا آنان در مسایل شخصی به داکتر مراجعه می‌کنند یا خیر؟ معمولاً در کنار داکتر، این افراد به چه کسانی به عنوان منبع جستجوی معلومات سلامتی می‌بینند؟ هدف از پردازش معلومات این است که چگونه بستر فرهنگی- اجتماعی بیمار یا مراقب بر درک، بیان و رسیدگی به بیماری و یا مراقبت از بیمار تاثیر می‌گذارد؟ به عنوان نمونه، از نگاه داکتر، بیمار، کسی است که به اثر مداخله و بررسی نظام مراقبت و مدافعه‌اش دچار مشکل شده است، به عکس، ممکن است خود بیمار، علت بیماری اش را از استرس و یا روابط اجتماعی دیگران با وی به میان آمده باشد.

هم‌رسانی معلومات مرتبط سلامتی می‌تواند با دو ابزار عمده ارتباطی اجرا شود: شیوه نخست، استفاده از رسانه‌های اصلی (از جمله، زبان کلامی و زبان غیرکلامی). شیوه دوم، استفاده از رسانه‌های جمعی است. ممکن است داکتری در مورد تغذیه عمومی در یک برنامه تلویزیونی صحبت کند. در این صورت، معلومات مرتبط به سلامتی از طریق تلویزیون هم‌رسانی شده است.

## ارتباطات عامل اساسی سلامت

ارتباط با سلامت رابطه‌ای مستقیم و تعاملی دارد. به هر اندازه ارتباطات فرد با محیط بهتر و مفیدتر باشد، به همان تناسب، سلامتی وی بیشتر تضمین است. از ۱۹۶۰ به این سوء دانشمندان بخش‌های سلامت متوجه این نقش ارتباط شدند. به همین دلیل، امروز ارتباطات را نه تنها عامل انتقال و دریافت معلومات مرتبط به سلامت می‌دانند، طوری که شرح دادیم، ارتباط را داری ماهیت شفا بخش هم دانسته‌اند. درعین زمان، ارتباط با صحت در مساله «انتخاب» نیز رابطه دارند. به عنوان نمونه، هر فرد می‌تواند، در صورت توان مالی، هر نوع غذا را مصرف کند، به عکس، این داکتر تغذیه است که با ارتباط میان فردی به وی تذکر می‌دهد که کدام پرهیزها را باید متوجه باشد. به عین شکل، این مراقبان بخش سلامت است که افراد جامعه را به آزمایش منظم بدن شان و اختیار کردن سبک پویای زندگی تشویق کنند.

از نگاه ماهیت، ارتباطات سلامت، وجهه تشویقی دارد. مراقبان، از طریق جستجوی معلومات مفید برای سلامت، پردازش آن‌ها و هم‌رسانی با افراد جامعه، شهروندان را تشویق به مراقبت از سلامتی شان می‌کنند. تشویق و هم‌رسانی معلومات مرتبط به سلامتی ممکن است از طریق ارتباط میان فردی رو در رو باشد یا از طریق رسانه‌های جمعی (برنامه‌های رادیویی و یا شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک) باشد.

بنابراین، دیده می‌شود که ارتباطات نقش حیاتی را در حصه مراقبت از سلامت و یا درمان بیماران می‌باشد.

## ماهیت مبادله‌ای ارتباط

برقراری ارتباط امری به شدت حساس به تفسیر است. تصور کنید که یکی از محصلان (مرد ۲۲ ساله) به یکبارگی از در سر صنف آمده و پیشروی تخته، این جمله را در حضور هم‌صنفانش بگوید: «من نامزاد شدم» وی با ارائه این جمله خواسته است با مخاطبان ارتباط برقرار کرده و هدف پیام (امیدواری به ..... ) را برساند. اکنون آیا هم‌صنفان وی با شنیدن هم‌چون جمله‌ای متعجب نخواهند شد؟ گروهی از شما بدشان بیایند؛ چون ممکن با خود بگویند که «هر سخن جایی و هر نقطه، مکانی دارد». شمار واکنش‌ها و برداشت از عین پیام، احتمال دارد خیلی بالاتر از تصور یک فرد گردد.

ارتباط، به عنوان بستر پیام، حامل معنی زیادی است. چنانچه یکی از دانشمندان عرصه ارتباطات به نام مک‌لوهان گفته است که «رسانه [بستر پیام]، خود، پیام است.» منظور وی این است که بستر در چگونگی جستجوی معلومات، پردازش معلومات و هم‌رسانی معلومات نقش حیاتی دارد. نکات بالا نشان داد که ارتباط امری پیچیده است و پیام، به سبب مداخله عوامل زمینه‌ای، قابلیت تفسیر شدن را دارد.

ارتباط مدل‌های متفاوت دارد. یکی از مدل‌ها به مدل «مبادله‌ای ارتباطات» موسوم است. طبق مدل مبادله‌ای ارتباط، فرستنده و گیرنده در شکل‌دهی معنای متن و پیام شریک اند. این شراکت در سطوح مختلف در بین فرستنده و گیرنده اتفاق می‌افتد.

## ابعاد ارتباط مبادله‌ای

برای درک مفهوم ارتباطات مبادله‌ای ابعادی را باید مدنظر داشت؛ معناسازی همکارانه، سطوح چندگانه معناسازی و اهمیت زمینه ارتباط و فرهنگ.

مفهوم معناسازی همکارانه این است که معنا از اشتراک در تجربه ارتباطی فرستنده و گیرنده به میان می‌آید. در مثال قبلی، «.....» پیام کامل نیست، بلکه، تعجب، نفرت و یا بی‌تفاوتی هم‌صنفان در کنار بیان‌شدن این جمله معنی جمله را کامل می‌کند؛ طوری که ممکن است پیام این جمله برای عده‌ای جالب باشد و برای دسته‌ای خنده‌دار. در مثال دیگر، تصور کنید که مردی معیوب پایِ پلاستیکی‌اش گم شده باشد و در پروسه جستجوی پایش از شما این گونه بپرسد: «پای مرا ندیدی؟» بیان این جمله، صرف به معنی این است که اگر پای مرا دیدی، آدرسش را بده. هرگاه همین جمله نوعی حسی از دلسوزی را به میان آورد، آن زمان، شما در خلق معنی شریک اید و یا حداقل در تکمیل بعد عاطفی پیام این جمله شرکت کرده‌اید. این اشتراک تأثیراتی دارد؛ از جمله این که دل شما سوخته و فردی معیوب را در یافتن پا کمک می‌کنید.

اشتراک در تولید معنا، معنی دیگر هم دارد. در همین مثال پای معیوب، زمانی که شما جمله پایم را ندیدی را می‌شنوید، نقش فرستنده به شما داده شده است، به عکس، هرگاه بعد از فاز همدردی شروع به جستجو می‌کنید، با کنش ارتباطی (جستجوی پای) به معیوب پیامی

می‌دهید که با او همدردی دارید. بنابراین، شما همزمان، با ترتیب زمانی، نقش فرستنده و گیرنده را بازی کرده اید.

معناسازی در سطوحی چند صورت می‌گیرد. معنی در سطح اول، لفظی است و در سطح دوم، رابطه‌ای. منظور از معناسازی در سطح لفظی طوری است که گیرنده پیام، صرف، خود کلمات را مورد نظر دارد. در مثال، پای مرا ندیدی، شما، به عنوان گیرنده، فقط همین را می‌دانید که فردی، پای پلاستیکی‌اش مفقود است. به عکس، در سطح رابطه‌ای، معنا با توجه به شاخصه‌هایی ایجاد می‌شود؛ مثلاً هرگاه شما همین جمله «پایم را ندیدی» را بشنوید، از خود می‌پرسید که این پیام «چگونه» بیان شد؟ «چه کسی» بیان کرد؟ در «چه زمانی» این جمله را شنیده‌اید؟ و این که این پیام چه چیزی را از شما «پنهان» می‌کند؟ با آن که این مفاهیم و نشانه‌ها در حین ارتباط میان فرستنده و گیرنده کمتر برجسته باشند، مگر، آن‌ها تأثیرات بزرگی را بر چگونگی ساخت معنا می‌گذارند. به عنوان مثال، اگر جمله «پای پلاستیکی‌ام را ندیدی» را از جوانی ۳۰ ساله در یک شام تاریک بشنویم، شاید شدت دلسوزی ما نسبت به وی بیشتر باشد. اگر همین جمله را از زنی ۳۰ ساله در نصف شب بشنویم، ممکن است، معنایی در ذهن ما خطور کند که آیا باید با وی همکاری کنیم یا نه؟ آیا وی در این نصف شب، چگونه از خانه بیرون شده است؟ آیا همکاری با وی به هدف توطئه‌ای نباشد!

زمینه و فرهنگ نیز عوامل تأثیرگذار بر معناسازی اند. به قول کلیفورد گیرتز، ما در شبکه‌ای از دلالت‌ها زندگی می‌کنیم. به عبارتی، بستر زندگی اجتماعی ما نوعی رابطه‌ای را شکل می‌دهد که بر شیوه ارتباط‌گیری ما اثر می‌گذارد. این بستر شامل عواملی چون تاریخچه گذشته‌ی

زندگی ما، محل زیست، طبقه اقتصادی، شیوه تربیتی در خانواده و گروه‌های اجتماعی مانند پوهنتون و یا نهادهای اجتماعی دیگر، فرهنگی که در آن بزرگ شده‌ایم و حتی میزان دسترسی ما به منابع می‌گردند. همه این عوامل باعث می‌شوند که ما نوعی از ارتباط و یا شیوه‌ای از ساخت معنا را مقبول ندانیم و عده‌ای را مردود. درعین زمان، همین بستر ما را بر شیوه تفسیر ما از واقعیت‌ها (ازجمله فرستادن پیام، تولید پیام و مصرف پیام) تاثیر بگذارد.

دیدگاه فرهنگی ما در مورد مفاهیم و معناها ارتباط‌گیری ما را متاثر می‌سازند.

## درس سوم

آنچه در این درس می‌خوانید:

- نگاه‌های شناخته‌ی مراقبت از سلامتی

## نگاه‌های معمول مراقبت از سلامت در جهان

تصور کنید که شما به بیماری مبتلا می‌شوید. عامل این بیماری چیست؟ هرگاه این بیماری را به میکروب (باکتری و یا ویروسی) نسبت بدهید، به گمانی مسایل مراقبت از سلامتی را با شیوه بدنی - طبی<sup>۴</sup> می‌بینید. اگر شما عامل بیماری را به عوامل دیگر (طرز تفکر، ارزش‌ها یا جامعه) ربط بدهید، با احتمالی، مساله را با شیوه بدنی - روانی اجتماعی<sup>۵</sup> تحلیل سلامتی دیده اید. هرگاه عین بیماری را به مفاهیم اجتماعی (سرمایه، فقر، پیش‌داوری‌ها) و یا محیط فرهنگی اسناد بدهید، وضعیت تان را با شیوه اجتماعی - فرهنگی سلامتی نگریسته‌اید.

### نگاه بدنی - طبی به سلامتی

گزاره مبنایی این شیوه نگاه این است که سلامتی یک امر فیزیکی (بدنی/جسمی) است که می‌توان آن را با ابزارهای فیزیکی به آن پرداخت. به این معنی که بیماری را می‌توان با ابزارهایی چون معاینه‌های فناورانه (عکس شعاع اکس) تشریح کرد و تشخیص داد. طبق این نگاه جسم انسان مانند ماشین است که اگر عضوی از آن کارآمدی نداشت مانند ترمیم‌کاران کامپیوتر، آن را با قطعه دیگر از بدن انسان دیگر تعویض کرد. به این صورت، درمان‌گران مانند ترمیم‌کاران در قدم نخست معلوماتی را در باره مشکل جمع‌آوری کرده و بعد از پردازش، عارضه را از بدن فرد دور می‌کنند. چنانچه محصلی طب پوهنتون کابل در رابطه به شیوه درمان بیماری اش

---

<sup>۴</sup> - Biomedical model

<sup>۵</sup> - Biopsychosocial model

گفت: «شخص، اول باید نزد داکتر مراجعه کند و باید تمام معاینات خود را تکمیل کند تا اول مدخل آن تشخیص شود و بعد برای بیماری اقدام کند.»

این شیوه نگاه به سلامتی/بیماری با انتقادهایی مواجه است؛ از جمله، منتقدان گفته اند که این شیوه بیماری و سلامتی را به امری کوچکتر تقلیل داده‌اند. طوری که آنان عوامل جانبی و مرتبط به سلامتی را در نظر نمی‌گیرند. به گفته منتقدان، گفتگوی درمان‌گر بدنی - طبی خیلی سطحی و به دنبال معلومات ابتدایی است. به عنوان نمونه، آنان می‌پرسند که «مشکل، از چه زمانی شروع شده؟ زمانی که این‌جا را می‌فشارم احساس درد می‌کنید؟ آیا تب داشتید؟» جواب این سوالات، فقط می‌توانند «بله» یا «نخیر» باشند. منتقدان از همین نکته انتقاد دارند که چگونه می‌شود با همچون معلومات سطحی بیماری تشخیص و درمان گردد؟ ممکن است عوامل دیگر (احساس و عواطف بیمار و تجربیات اجتماعی بیمار) هم در کار باشند که درمان‌گر آنان را در پروسه تشخیص و درمان در نظر نمی‌گیرند. آنان اعتراض دارند که این شیوه افراد را به موجودی ساخته شده از اجزا و اعراض تقلیل داده‌اند.

### نگاه بدنی - روانی - اجتماعی به سلامتی

این شیوه همزمان وضعیت فیزیکی (جسمی)، طرز تفکر و عقاید آنان (روانی) و توقعات اجتماعی آنان را در حین برخورد با سلامتی/بیماری فرد را مدنظر دارند. طبق این دیدگاه، بیماری صرف مساله جسمی نبوده، بلکه زیر تاثیر عواملی چون احساسات بیمار، طرز نگاه وی به سلامتی و رخدادهای زندگی آنان نیز قرار دارد. این شیوه تاکید دارد که نمی‌توان یک شیوه خاص را

برای همه جواب‌گو دانست. به عنوان نمونه، ممکن است پیرمردی نیازمند به مراقبت، استخدام یک مراقب خانه را مزاحم و ترسناک تلقی کند. درحالی که پیرمردی دیگر وجود همچون مراقب را غنیمت بشمارد. به عین شکل، شاید مشکلات تنهایی زنی سالخورده با قصه با یک مراقب حل شود، ولی مشکلات تنهایی زن همسایه همین زن را بدون تجویز دارو درمان نتوانیم. چنانچه دختر زنی سالخورده و دچار آلزایمر به مترجم گفت که مادرش چون دچار فراموشی است، یک قصه را شاید ده‌ها بار تعریف کند. درعین زمان، حسی دارد که باید تمام لحظات فرزندانش را ببیند. تا زمانی که همه آنان از کار برنگردد، مدام در تشویش است. همین خانم افزود که حتی اگر کنار مادرش باشیم و قصه‌اش را هم بشنویم، باز هم احساس تنهایی او را رها نمی‌کند. این نشان می‌دهد که این زن سالخورده درمانی ندارد، مگر این که با شیوه بدنی-طبی داروهای ضدفراموشی به وی بدهند.

تحقیقات نشان داده اند که حمایت اعضای جامعه بر سلامتی یا وخامت بیماری فرد اثر دارد. زیرا این پشتیبانی بر احساس و طرز تفکر بیمار تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، هرگاه به عیادت بیماری برویم، حسی از امید و اطمینان به بهبودی در وی القاء کرده ایم.

پژوهش‌هایی در مورد تاثیر نگاه و احساس فرد نسبت به بیماری و سلامتی عمومی و هم‌چنان توان مقابله در مقابل بیماری انجام شده اند. چنانچه ثابت شده است که استرس عاطفی بر ضربان قلب اثر و یا فشار خون تاثیر دارد. آنان اکنون دریافته اند که استرس بلند بر قدرت‌گیری بیماری فشار خون اثر دارد (موس و همکاران، ۲۰۱۱). به عکس، رخ دیگر سکه این است که

خوش خلقی، خوش بینی نسبت به سلامتی و جهان و حمایت اجتماعی بیمار را در مقابله به بیماری‌ها توانا تر می‌سازد (گالاگیر، فیلیپس و همکاران و کارول، ۲۰۰۸).

### نگاه فرهنگی - اجتماعی به سلامتی

به اساس این شیوه، سلامتی مجموعه‌ای از تاثیرات پیچیده و تعاملی عوامل زیادی اند؛ از جمله، انتخاب فرد، تحرکات اجتماعی و فرهنگ.

در این شیوه، عوامل مرتبط به بعد اجتماعی سلامت، شامل میزان سرمایه و یا میزان فقر افراد (طبقه اقتصادی)، پیش‌ذهنیت‌ها (کلیشه‌ها) در مورد سلامتی و میزان دسترسی به خدمات مراقبت از سلامتی می‌شود. به هر اندازه میزان درآمد فرد بالاتر باشد، میزان دسترسی وی به خدمات بهتر درمانی بهتر است. وی ممکن است بیمه سلامتی و بیمه عمر داشته باشد. به همین دلیل، وی نه استرس بیماری کنونی را دارد و نه با نگرانی بیماری‌های سالخوردی مواجه است. درعین زمان، ممکن است همین فرد، کلیشه‌های نسبت به سلامتی نیز داشته باشد. به عنوان نمونه، شاید از مراجعه به موقع به داکتر خوشش نیاید؛ چون دارو و درمانی داکتری را خلاف نظم طبیعی بدنش بداند.

بعد فرهنگی این نگاه به سلامتی بیشتر به ارزش‌ها و مناسک مشترک فرد با جامعه اطراف وی می‌گردد.

## نگاه کارآمد

هیچ کدام از این شیوه‌ها به تنهایی کارآمد نیستند. چنانچه رویکرد بدنی- روانی - اجتماعی با توجه به این که همزمان به سه بعد توجه دارد، ممکن است پرترفدار باشد؛ مگر، همین شیوه در برخی از موارد کارآمد نیست. بنابراین، بهترین چاره این است که فرد همزمان سه شیوه را دانسته و در مواقع ضروری از آن بهره ببرد. به عنوان نمونه، شیوه فرهنگی- اجتماعی و شیوه بدنی- روانی - اجتماعی برای مراقبت عادی از سلامت و یا درمان‌های عادی موثر است؛ مگر برای بیماری‌های عاجل و یا پیشرفته جواب نمی‌دهد. بنابراین، بهتر است از رویکرد بدنی- طبّی استفاده شود.

## درس چهارم

آنچه در این درس می‌خوانید:

- مسایل تاثیرگذار بر کیفیت و کمیت ارتباطات سلامت (جمعیت، میزان و کیفیت سلامت عمومی و مداخله فناوری در عرصه سلامت).

## مسایل مطرح در عرصه مراقبت از سلامت

ارتباطات سلامت، متأثر از عوامل متفاوت زمینه‌ای است. یکی از این عوامل مسایل مطرح در عرصه مراقبت از سلامت است. این عامل ماهیت ارتباط‌گیری و تعریف سلامت را متأثر می‌سازد و بنابراین، در یک دهه آمدنی ممکن است بر تعریف ارتباطات سلامت (جستجو، پردازش و هم‌رسانی معلومات مرتبط به سلامت) دچار تفاوت‌هایی گردد. به عنوان نمونه، با مداخله فناوری در عرصه تشخیص میزان سلامتی و یا ارائه خدمات مراقبت از سلامت و یا خدمات درمانی، شیوه‌های جدید هم‌رسانی به میان آمده‌اند. این نکته و سایر نکات مطرح عرصه مراقبت از سلامت در این درس پوشش داده خواهد شد.

## خدمات وقایه‌ای

قول معروف جامعه ما این است که «وقایه، بهتر از درمان است». تحقیقات علمی هم نشان داده‌اند که هرگاه فرد در مقابل امراضی مانند تنگی نفس، دیابت، سرطان، چاقی یا سایر امراض مراقبت‌های وقایه‌ای داشته باشد، هیچ‌گاهی سر به بخش عاجل شفاخانه و یا امبولانس عاجل نخواهد رسید. البته، رعایت اقدامات وقایه‌ای به عواملی مرتبط است؛ از جمله، مدیریت زمان و اولویت‌بندی فعالیت‌های زندگی و توان مالی فرد و یا کل نظام در وقایه.

مدیریت زمان و اولویت‌بندی فعالیت‌های روزمره نمایان‌گر این است که فرد اقدام‌های مراقبت از سلامتی به چه میزانی اولویت می‌دهد و چگونه زمان را مدیریت می‌کند تا بخشی از زمان را به رسیدگی به امور سلامتی هم اختصاص بدهد. از طرفی، با توجه به سریع‌شدن روندهای

زندگی، زندگی با فعالیت‌های متراکم و همزمان همراه است. به همین دلیل، فردی عصر امروزی باید همزمان چندین کار را انجام دهد. این کار شدنی نیست؛ مگر ایجاد اولویت در میان آن‌ها. به همین دلیل، باید مهارت مدیریت زمان و اولویت‌بندی فعالیت‌ها را آموخته باشد.

یکی از سازوکارهای مدیریت زمان به اساس حیاتی‌بودن فعالیت‌ها، استفاده از پنجره جوهری<sup>۶</sup> است. شرح این جدول در زیر آمده است. طبق این جدول نوعی، وقایه در خانه غیرعاجل و مهم قرار داده شده است. هرگاه مدیریت کارها و زمان‌بندی به این شکل نباشد، بیماری حاد شده و در این صورت است که فرد، به عنوان نمونه، دچار اپاندکس شده و بنابراین، در خانه عاجل و مهم قرار می‌گیرد. لذا، بهترین حالت برای زندگی مدرن و پرمشغله این است که فرد همیشه به کارهای غیرعاجل و مهم بپردازد. به عنوان نمونه همیشه باید به وقایه اهمیت بدهد تا وقوع بلاء قبل از واقعه صورت بگیرد.

تغییر عادات زندگی مردم به نفع اقدام جهت وقایه مستلزم به کارگیری شگردهای ارتباطی است. در این میان، رسانه‌های جمعی می‌توانند با ارائه پیام‌های تشویقی، پخش برنامه‌های رهنمایی ورزش یا سایر برنامه‌ها وقایه را به عنوان ارزش اجتماعی در ذهن افراد اجتماعی کند.

---

<sup>۶</sup> Johhari window

| غیرعاجل                                                                                                                                                                                                                      | عاجل                                                                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- آمادگی‌ها</li> <li>- وقایه</li> <li>- برنامه‌ریزی</li> <li>- ایجاد روابط</li> <li>- توانمندسازی</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- بحران‌ها</li> <li>- مهلت آخر انجام کار</li> <li>- پروژه‌ها</li> <li>- جلسات</li> <li>- آماده‌گی</li> </ul>       | ۳ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- صحبت در مورد همه چه و هیچ چه</li> <li>- برخی از تماس‌های تلفنی</li> <li>- کاری بی‌تمرکز</li> <li>- ساعت‌تیری</li> <li>- ایمیل‌های بی‌ربط</li> <li>- تماشای مفرط تلویزیون</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مزاحمت‌ها (تماس تلفنی، ایمیلی)</li> <li>- برخی جلسات</li> <li>- فعالیت‌های عام</li> <li>- کارهای فوری</li> </ul> | ۳ |

خدمات وقایه‌ای نکته دیگر هم دارد: نیازمند زیرساخت قوی و کارآمد و میزان درآمد مناسب است. به عنوان نمونه، در جاپان سالانه برای خدمات سلامتی هر فرد سه هزار دالر آمریکایی مصرف می‌شود؛ درحالی‌که در آمریکا این مبلغ به هشت هزار دالر می‌رسد. نکته جالب این است که صحت و سلامتی جاپانی‌ها نسبت به آمریکاییان بیشتر است. دلیلش این است که جاپان مبلغ اختصاصی هر فرد را بر خدمات وقایه‌ای، مراقبت منظم و تشخیص به‌موقع بیماری مصرف می‌کند (سازمان سلامت جهانی، ۲۰۱۲).

## کیفیت خدمات

منظور از کیفیت خدمات مراقبت از سلامتی این است که آیا میان مقدار مصرف برای مراقبت از سلامت و درمان و هم‌چنان خدمات مراقبتی و درمانی توازن هست یا نه؟ در برخی از کشورها، مانند آمریکا، با آن که مقدار زیادی از بودجه برای خدمات مراقبت از سلامت اختصاص می‌یابد، عده‌ای زیاد از شهروندان این کشور خدمات درست درمانی و مراقبتی دریافت نمی‌کنند. از طرفی، سرعت افزایش قیمت بیمه سلامتی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ ده برابر بیشتر شده است. در عین زمان، در این کشور پنجاه میلیون تن (یک تن از شش تن) بیمه سلامتی ندارند. این افراد چون بیمه ندارند، به صورت منظم برای دریافت خدمات سلامتی مراجعه نمی‌توانند و صرف زمانی این خدمات را می‌خرند که بیماری آنان خیلی جدی گردد. بنابراین، در آمریکا کیفیت خدمات مراقبت از سلامتی و درمان نسبت به برخی از کشورهای دیگر نازل است و این وضعیت هر روز تشدید می‌شود.

افغانستان با اختصاص ۸,۶ درصد بودجه کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ به خدمات مراقبت صحتی، با آن که ادعا دارد که خدمات عمومی درمانی و مراقبتی را برای تمام افغان‌ها عرضه می‌کند، تحقیقات و شواهد متضاد آن را نشان داده‌اند. چنانچه ارقام در سال ۱۳۹۳ نشان داد که «۹۰ درصد مردم روستایی به پسته‌های صحتی یا کلینیک‌های دسترسی دارند که دو ساعت راه از آنان فاصله دارند. درحالی که صرفاً یک چهارم از بیماران، به سبب شرایط سخت و سرمای زمستان به مراکز مراقبت صحتی و یا کلینیک‌های شخصی رسیده می‌توانند.» (ستیلی، ا و فریور، ف و همکاران، بی‌تا). از طرفی، با توجه به این که بیمه سلامت در افغانستان به مفهوم عام آن

وجود ندارد، شهروندان به صورت منظم نمی‌توانند برای استفاده از خدمات مراقبتی و درمانی به شفاخانه‌ها مراجعه کنند. چنانچه گزارش فقر چندبعدی (۲۰۱۶) وزارت اقتصاد نشان داد که «۵۱,۷ درصد افغان‌ها از چند بعد فقیر اند. شدت فقر چند بعدی ۵۲,۵ درصد است. به این معنی که ۵۲,۵ درصد افغان‌ها از سلامتی، تعلیم و تربیه، معیارهای عادی زندگی، شغل و داشتن زندگی عادی محروم اند.»

در کنار این نکات، ارتباط ناکارآمد عرضه‌کنندگان خدمات مراقبتی- درمانی یکی از عواملی است که افغان‌ها را وادار به رفتن به هندوستان جهت استفاده از خدمات درمانی آن‌جا می‌کند. رفتن به هندوستان و نداشتن بیمه و توان دسترسی کارآمد به خدمات صحتی به سبب فقر چندبعدی، تناقضی است که می‌توان را مفهوم پایین بودن کیفیت خدمات مراقبتی- درمانی در افغانستان با هم ربط دارد؛ باوجودی که چهل درصد افغان‌ها از فقر چندبعدی رنج می‌برند، مگر چگونه حاضر اند، هزاران دالر را برای دریافت خدمات سلامتی در مسیر هند مصرف کنند؟

## طب سنتی در خاورمیانه

در کنار این رویکردهای معمول جهانی، در سنت اکثریت تمدن‌ها و کشورها، نوعی طب سنتی نیز داریم. طب سنتی بیشتر بر دانش بومی استوار است.

طب سنتی در خاورمیانه (به ویژه کشورهای اسلامی) دو رویکرد معمول طب سنتی، استفاده از داروهایی علفی (موسوم به داروهای یونانی) و توسل به ادعیه و نیایش است. این رویکردها از جمله، رویکردهای معمول درمانی به حساب می‌آیند (کاکر، ۱۳۸۸).

از طرفی، مردم به صورت عادی مشتریان این رویکرد هستند. چنانچه از شهروندانی در کابل پرسیده شد که زمانی آنان بیمار می‌شوند، چه می‌کنند؟ عده‌ای جواب دادند که از داروها و رویکرد طب سنتی استفاده می‌کند و اگر بیماری نیازمند درمان عاجل و کوتاه‌مدت بود، از رویکرد بدنی - طبی استفاده می‌کنند. شرح این نظریات را در جدول زیر می‌خوانیم. در این جدول نظریات ضد طب سنتی نیز هست.

| مشخصات                                                                      | نظر                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زن، ۶۰ ساله، بدون تحصیلات، کابلی.                                           | برای درد و میکروب معده از اسفرزه، برای اسهال اطفال از چای خشک کوبیده و برای سردردی از جوشانده گل‌باپونه استفاده می‌کنم. تا داروهای یونانی باشد، حاجت به داکتر نیست. |
| محمد شفیع، میانه سال کارگر، جلال‌آبادی و مردی ۶۷ ساله، متقاعد و زنی ۵۰ ساله | برای بیماری‌هایی که جدی نیستند، از ادویه یونانی استفاده می‌کنیم. بیمار می‌شوم در چشم آفتاب استراحت می‌کنم.                                                          |

|                                                    |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زنی ۵۰ ساله و محصلی ۲۲ ساله و<br>محصلی طب ۲۷ ساله. | پیش داکتر می‌روم. هر مریضی تداوی خاص خودش را دارد. اگر ابتدایی باشد، تداوی آن خانگی [طب سنتی] است و اگر به آن علاج نشد، به داکتر مراجعه می‌کنم. |
| مردی میان‌سال                                      | اگر بیمار شوم، نزد ملای مسجد می‌روم. خدا مهربان است که سلامتی‌ام را باز یابم.                                                                   |
| محصلی داروسازی، ۲۲ ساله                            | از برخی غذاها پرهیز می‌کنم. دارو می‌گیرم.                                                                                                       |
| زن، ۴۴ ساله                                        | اول یک‌تا تابلت پرستامول می‌گیرم و اگر نشد، از دواخانه منطقه تابلت جان‌دردی می‌گیرم.                                                            |
| مردی ۳۴ ساله، صفاکار لیلیه                         | نیم‌سری داشته باشم، پیش ملا صاحب می‌روم و تعویذ می‌گیرم و همیشه قبل از این که مریض شوی قل هوالله (سوره توحید) بخوانی، مریض نمی‌شوی.             |
| مردی ۴۵ ساله، داکتر                                | زمانی که احساس درد یا خستگی کنم، داروی آرامش‌بخش استفاده می‌کنم. اگر موثر نبود، از هم‌مسلمانم می‌خواهم مرا تداوی کند.                           |
| مردی ۵۰ ساله، صفاکار لیلیه                         | هیچ وقت پیش داکتر نمی‌روم و اگر خیلی پاهایم درد کند، یک چهارم تابلت استفاده می‌کنم. تابلت اگر معده‌ات را جور کنه، گرده را خراب می‌کند.          |
| مردی ۴۰ ساله، راننده تاکسی                         | طب سنتی از آنقدر کارا نیست. طبیبان سنتی برای هر مریضی جوشانده‌اش تیار است.                                                                      |

با مطالعه این جدول به این نتیجه می‌رسیم که به تناسبی که سطح و نوع تحصیلات، میزان درآمد و نوعیت شغل فرد متفاوت باشد، رویکرد مورد استفاده نیز متفاوت می‌گردد. درضمن، توقع بیمار از میزان و سرعت تاثیر دارو نیز عامل مهم در گزینش رویکرد مراقبتی- درمانی است. به تناسبی که بیمار بخواهد سریعتر، سالم گردد، باید از خدمات قویتر بدنی- طبی استفاده کند.

## تغییر در کیفیت جمعیت

مهاجرت یکی از پدیده‌های عام زندگی جهان مدرن است. از طرفی، هر مهاجر، با توجه به وابستگی اش به فرهنگی خاص، دیدگاه خاص به بیماری و سلامتی هم دارد. وی در مهاجرت همان دیدگاه را با خود می‌برد. درعین زمان، میزان درآمد و سطح تحصیلات و سبک زندگی مهاجران با مردم بومی ممکن است همسان نباشد. بنابراین، این مهاجران، کیفیت کشورهای مهاجرپذیر را تغییر می‌دهد. ممکن است این تغییر به سمت بهبودی باشد و ارتباطات سلامت مهاجران و جامعه میزبان بهتر و باکیفیت‌تر گردد و البته احتمال عکس آن هم هست.

جابجایی داخلی، به اثر فقر روستاها، خشکسالی و عوامل دیگر، نیز کیفیت شهرهای بزرگ را از منظر استفاده از خدمات سلامتی و شیوه‌های برقراری ارتباطات سلامت متحول کرده است. بافت و زیست زندگی روستایی شیوه خاص برخورد با بیماری و سلامتی را دارد. چنانچه، در جدول نظریات افراد در مورد طب سنتی آمد، به تناسبی که جواب‌گویان روستایی بیشتر متمایل به استفاده از طب سنتی بودند. به عکس، افرادی شهری و طبقه متوسط بیشتر طرفدار خدمات صحتی اند.

میزان دسترسی به خدمات مراقبت از سلامت نیز عامل مهم در ایجاد تغییر در کیفیت جمعیت یک کشور است. به عبارتی، میزان فقر در شهرها به تناسب روستاها و ولایاتی خاص متفاوت است. این عامل باعث می‌گردد که ما در عین کشور با دو نوع کیفیت جمعیتی مواجهه داشته باشیم: جمعیتی برخوردار و جمعیتی محروم از خدمات سلامتی. چنانچه طبق گزارش فقر چند بعدی (محتوای گزارش).

جمعیت محروم از خدمات مراقبت از سلامتی، در عرصه ارتباطات سلامت مشکلات بیشتر دارند. به این معنی که آنان در جستجوی منابع تامین خدمات مراقبتی- درمانی، شیوه پردازش این معلومات و حتی هم‌رسانی این معلومات مشکلاتی دارند. به عبارت دیگر، میزان سواد سلامتی در نزد این افراد پایین است. به همین دلیل، هر از گاهی در معرض سوء تفاهم‌های خطرناک در مورد مسایل سلامتی، درمان ناقص، رنج‌های قابل‌پیشگیری و مراجعه به مراکز سلامتی قرار دارند (دوپری، ۲۰۱۷: ۲۳). چنانچه تحقیقاتی که بر شیوه‌های جستجو، پردازش و هم‌رسانی معلومات مرتبط به سلامتی در میان مهاجران افغانی، ایرانی و عراقی انجام شده است، بیانگر این است که به عنوان نمونه، افغان‌ها، عادات عجله و اضطراب در پروسه درمان را از کشور اصلی شان به استرالیا نیز برده است. چنانچه، یکی از آنان به محقق گفت است: «اگر بیمار خدمات مورد نیازش را نیابد، با داکتر خانوادگی‌اش تماس می‌گیرد. وی بیمار را به متخصص ارجاع می‌دهد... سه ماه تا شش ماه می‌گذرد تا نوبت ملاقات متخصص بگذرد... [طی این مدت] بیمار یا می‌میرد و یا بیماری‌اش تشدید می‌شود.» (اندریا نیل، جمیله ابودووهو و همکاران، ۲۰۰۷: ۲۷۳).

این گزارش نشان می‌دهد که به تناسبی که مهاجران از کشورها، فرهنگ و نژادهای متفاوت با دیدگاه‌های متفاوت راجع به سلامتی به استرالیا سرازیر می‌شوند، جمعیت این کشور کیفیت متفاوت می‌گیرد. چنانچه از این که نظام مراقبت سلامتی در افغانستان به اساس معالجه استوار است، افغان‌ها عادت به وقایه ندارند. به عکس، تا زمانی که بیماری آنان را از پا نیانداخته، به خدمات مراقبتی مراجعه نمی‌کنند. از طرفی، سیستم خدمات مراقبت سلامتی استرالیا به اساس نظام وقایه‌ای بنا شده است. بنابراین، برای افغان‌ها تازه وارد این خبر بی‌مفهوم است که برای ملاقات یک متخصص از سه ماه تا

شش ماه منتظر بمانند؛ چون در کشور شان اکثریت متخصصان را به زودترین فرصت ملاقات می‌توانند. به همین دلیل، آن گونه که پژوهش‌گران پیشنهاد کرده‌اند، باید اقداماتی را جهت تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و مراقبتی روی دست بگیرد؛ از جمله، بر ارتباطات سلامتی در مورد مهاجران توجه جدی‌تر کند.

### توانمندشدن بیمار

مساله مهم دیگر در عرصه ارتباطات سلامت، توانمندشدن، بیماران و نیازمندان مراقبت سلامتی است. این تغییر به سبب عواملی به میان آمده است. نخست، رسانه‌های جمعی یکی از منابع هم‌رسانی معلومات سلامتی است. افراد عادی اکنون با مصرف برنامه‌های سلامتی در معرض معلوماتی قرار می‌گیرند که تاکنون صرف متخصصان بخش آن‌ها را می‌دانستند. دوم، گسترش آموزش همگانی، سطح سواد عام را در مورد مسایل سلامتی افزایش داده است. از طرفی، جمعیت امروزی تحصیل کرده، از نگاه روابط قدرت و منابع اعتماد به نفس متفاوت‌تر از نسلی بی‌تحصیل‌اند. نسل تحصیل کرده امروزی، در مواجهه با متخصصان سلامت با تکیه به معلومات کسب‌شده از رسانه‌های جمعی و مهارت‌های ارتباطی- گفتگویی، تأثیراتی در ارتباط سلامت می‌گذارند. به این معنی که شیوه‌ی درخواست معلومات آنان از متخصصان، پردازش این معلومات و حتی هم‌رسانی آن با افراد دیگر جامعه دچار تفاوت شده است. به این صورت، متخصصان بخش سلامتی به مرور به این نکته پی می‌برند که آنان مختار مطلق بر روند تصمیم‌گیری در مورد سلامت افراد نیست، بلکه، به عنوان یکی از طرفین گفتگوی تصمیم‌گیری و به حیث مشاور عمل می‌کنند.

توانمندشدن بیماران، در افغانستان نیز تا حدی موضوعیت دارد. طبق گزارش ها میزان سواد همگانی به چهل درصد رسیده است. این رشد، تبعاتی را با خود دارد؛ از جمله، بر دیدگاه شهروندان راجع به سلامتی و تامین کنندگان خدمات سلامتی تاثیر می گذارد؛ گرچند میزان چهل درصد باسوادى در سطح کشور به آن اندازه چشمگیر نیست که در کوتاه مدت بتوان به سرعت توانمندشدن بیماران خوشبین بود.

### استفاده از فناوری

فناوری زمینه جستجو، پردازش و هم‌رسانی اطلاعات مرتبط به سلامتی را متحول کرده است. شبکه‌های اجتماعی، وبسایت‌ها، شبکه‌های مخابراتی موبایل (پیام‌ها)، تلویزیون‌ها، یوتیوب و ارائه خدمات مشاوره مراقبتی- درمانی از راه دور زمینه دسترسی به معلومات مرتبط به سلامتی را برای همه مساعد ساخته اند. چنانچه هم‌اکنون خدمات درمانی از طریق اینترنت زمینه برقراری ارتباط میان داکتر از فاصله خیلی دور و بیمار را مساعد کرده است. از طرفی، خبر خوش این است که هرکدام از طبقات و اقشار جامعه رسانه مورد نظر خود را دارند تا معلومات مرتبط به سلامت را از آن طریق دریافت کنند. کسانی که به اینترنت دسترسی دارند به سادگی می‌توانند معلومات صحی برگرفته از تجارب و دانش خود را از طریق کلیپ‌های صوتی (در قالب پادکست) و کلیپ‌های ویدیویی نشر کنند. درعین زمان، گیرندگان زمینه سوال و ارائه نظریات را دارند. به عبارتی، رسانه‌های چند منظوره کار مراقبت از سلامتی و درمان را عام‌تر و همگانی‌تر گردانیده اند.

آنانی که در جامعه‌ی مانند افغانستان که شصت درصد آنان سواد خواندن و نوشتن (به قولی استفاده از فناوری‌های بر اینترنت، مانند ایمیل و یوتیوب ...) را ندارند، تلویزیون‌ها برنامه‌های سلامتی ارائه می‌کنند. در کنار آن، اکنون نرم‌افزارهای خاص جهت بررسی میزان شاخص‌های مهم شخص طراحی شده است تا نتایج آن را با متخصصان مراقبت شریک کنند. در دنیای فناوری سخت‌افزار، اکنون فناوری دست بالایی به بیماران داده است؛ چنانچه، با اختراع دستگاه چک میزان قند یا فشار خون، هر فرد بیمار می‌تواند وضعیت سلامت خود را از این دو ناحیه، خود، بررسی کرده و یا با گزارش نتایج آن به متخصصان از راه دور تدابیر مراقبتی- درمانی دریافت کنند.

چنانچه یکی از تلویزیون‌ها با عنوان چراغ برنامه‌های آموزشی طبی را نیز به مصرف‌کنندگان (از جمله محصلان) عرضه می‌کند. به عین شکل، رادیوها نیز برنامه‌های مرتبط به سلامت دارند. درعین زمان، سلامت عمومی به عنوان مضمونی در نظام معارف وارد شده است.

این نکات پایان انحصار متخصصان مراقبت از سلامت و خدمات درمانی را نشان می‌دهند. به عبارتی، شهروندان امروزی با داشتن توان مهارت خواندن و نوشتن و معلومات زمینه‌ای می‌توانند معلومات سلامتی مورد نیاز شان را جستجو و با کمک دیگران پردازش و از طریق رسانه‌ها آن را شریک کنند. بنابراین، عرصه ارتباطات سلامت را دچار تحول کرده است.

این تحول، در کشورهای صنعتی بیشتر مشهود و مزده بخش اند؛ مگر در کشورهایی مانند افغانستان که سطح سواد عمومی و سواد سلامتی پایین است و پوشش اینترنت محدود به شهرهای بزرگ، اندکی زودتر است که فناوری را عامل پرکننده‌ی شکاف میان متخصصان مراقبت از سلامت و

درمانگران و شهروندان (از جمله، بیماران) تلقی کرد. بنابراین، در افغانستان الگوی غالب ارتباطات سلامت، بر اساس ارتباط یکطرفه و سنتی انتقال معلومات از طریق مراقبان به بیماران استوار است. سازوکار شریک کردن معلومات نیز، به اساس سازوکارهای فناورانه‌ی اولیه استوار است. چنانچه اکثریت خدمات مراقبتی - درمانی در افغانستان به اساس ارتباط میان فردی رودررو و با رسانه‌های اولیه (مانند زبان گفتاری) عرضه می‌گردد.

## درس پنجم

در این درس می‌خوانید که:

- در جریان درمان، میان مراقب و بیمار چه می‌گذرد؟
- چه کسی بیشتر صحبت می‌کند؟ چرا؟
- چه کسی تصمیم‌نهایی شیوه درمان را می‌گیرد؟ چگونه؟

## تفاوت میزان اقتدار در گفت‌وگوی بیمار-مراقب

بیماران و مراقبان دارای سطوح متفاوتی از اقتدار هستند. این تفاوت به عواملی مثل دانش، مهارت در به‌کارگیری تکنولوژی، موقعیت اجتماعی-اقتصادی، دسترسی به منابع، یا داشتن بیماری خاص بستگی دارد. از دیدگاه «تیمورمن»، یکی از چهارچوب‌های سنتی (کلاسیک) برای بررسی ارتباط بیمار و مراقب، همین تفاوت در اقتدار است که بر تعامل آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

بیماران تلاش می‌کنند کنترل بیشتری بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به درمان خود داشته باشند، حتی اگر توانایی کامل در شناخت بیماری را نداشته باشند. مراقبان، با تکیه بر دانش تخصصی و تجربه‌شان، سعی می‌کنند راهنمایی و همکاری لازم را به بیماران ارائه دهند. در گفت‌وگوهای بیمار و مراقب، استفاده از منابع قدرت و میزان دانش هر فرد، به شکل‌گیری رابطه تأثیر می‌گذارد.

## دانش و قدرت

یکی از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری قدرت، میزان دانش فرد است. هرچقدر فرد اطلاعات بیشتری درباره بیماری، درمان و پروسه مراقبت داشته باشد، نفوذ بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها پیدا می‌کند. این اطلاعات می‌توانند از منابع رسمی یا تجربه‌های شخصی به دست آمده باشند.

نکته‌ای که «فیشکین» مطرح کرده این است که دسترسی نابرابر به اطلاعات باعث می‌شود برخی بیماران در تعامل با مراقب، نقش منفعل‌تری داشته باشند. افرادی که اطلاعات بیشتری دارند، قدرت بیشتری در گفتگوها دارند. برخی مراقبان با استفاده از اصطلاحات پیچیده طبی و زبان علمی، به‌طور

ناخودآگاه یا آگاهانه، فاصله دانش را بیشتر می‌کنند. این باعث می‌شود بیماران نتوانند به‌درستی در تصمیم‌گیری مشارکت کنند.

### گویندگان: شنوندگان

در بیشتر گفتگوهای درمانی، مراقبان (داکتران) سهم بیشتری از صحبت‌ها را دارند. پژوهشی نشان داده که داکتران در گفتگو با بیماران، در ۶۰ تا ۶۵ درصد مواقع، آغازکننده صحبت هستند.

مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۷ در آمریکا نشان داد که داکتران اغلب مکالمات را با پرسش‌های بسته شروع می‌کنند و صحبت بیماران را قطع می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود که بیماران نتوانند آزادانه افکار و نگرانی‌های خود را بیان کنند.

میزان سهم بیمار در گفت‌وگو با مأموریت بیمار در تعامل دارد. تحقیقات نشان داده که بیماران در مقابل تیم درمان سهم کمتری در گفت‌وگو دارند. حتی ممکن است یک داکتر، عمده سخنان را در ارائه اطلاعات و پرسش و پاسخ گفته، سهم کمی برای بیمار باقی بماند. پژوهشی (فردوسی ۲۰۱۷) با موضوع تعاملات بین ۱۱۲ داکتر و ۱۱۹ بیمار، نشان داد که داکتران در ۶۵٪ گفت‌وگوها، شروع‌کننده هستند. در ادامه نیز داکتر گفت‌وگو را هدایت می‌کند، به گونه‌ای که گاه کنترل گفت‌وگو به نحوی در اختیار او قرار می‌گیرد که بیمار امکان مشارکت در بیان نظرات و تصمیم‌گیری را پیدا نمی‌کند. گاه دیده می‌شود که بسته به شیوه آغاز گفت‌وگو توسط داکتر، نتیجه درمان نیز تعیین می‌شود.

## مشارکت بیمار در درمان

روابط بیمار و مراقب زمانی مؤثر و پایدار خواهد بود که آن همی در بیمار و علائم و حتی تمایلات درمانی او با شیوه درست دیده شود. هر چه ارتباط میان داکتر و بیمار سالم‌تر باشد، کیفیت درمان بالاتر خواهد بود. تحقیقات نشان می‌دهد، بیمارانی که در تصمیم‌های سلامت خود تجربه شرکت در پروسه درمان را داشته‌اند، احساس امنیت و رضایت بیشتری دارند. این مشارکت زمانی مؤثر است، که بیمار با استفاده از منابع اطلاعاتی آمادگی تحلیل و درک گزینه‌های درمانی و تصمیم‌گیری مناسب را داشته باشد. از این‌رو آموزش به بیمار، تهیه منابع مناسب و توانمندسازی او در درک شرایط درمانی، کیفیت پروسه درمان را افزایش می‌دهد. بیمار به‌ویژه در صورتی که به‌درستی دیده و شنیده شود، می‌تواند با مراقب همکاری مؤثرتری کند.

اگرچه ممکن است بیماران توانایی بیان دلایل درمانی یا مشکلات طبی را نداشته باشند، اما تجربه زیست آن‌ها می‌تواند در روند درمان بسیار اثرگذار باشد. بنابراین سهم گفت‌وگو در بیمار و میزان مشارکت او در تصمیم‌گیری‌های درمانی، نه تنها به سطح سواد سلامت او، بلکه به رابطه‌ای بستگی دارد که با مراقب شکل می‌گیرد. داکتر نیز یکی از دلایل تأکید بر رابطه درمانی و توجه به بیمار، افزایش سطح آگاهی بیماران از حقوق خود، و دسترسی به منابع اطلاعاتی و تجربیات در فضای گسترده‌تری است که به مشارکت مؤثرتر آن‌ها منجر می‌شود.

## پرسش و هدایت

پرسش و هدایت یکی از عناصر کلیدی در تعامل میان ارائه‌دهندگان خدمات سلامت (مانند داکتر، پرستار، مشاور) و بیمار است. این مفهوم به نحوه طرح سؤالات و هدایت مکالمه از سوی مراقبان اشاره دارد که می‌تواند بر درک، اعتماد، مشارکت بیمار و نتیجه درمان اثر مستقیم بگذارد.

## پرسش

پرسیدن سؤال از بیمار، فقط دریافت اطلاعات نیست؛ بلکه یک ابزار ارتباطی است که:

- فضای گفت‌وگو را باز می‌کند؛
  - به بیمار احساس ارزشمندی می‌دهد؛
  - روند تشخیص را بهبود می‌بخشد؛
  - بیمار را به مشارکت فعال‌تر در درمان ترغیب می‌کند.
- پرسش‌ها می‌توانند باز (مثل: «چه احساسی دارید؟» یا بسته (مثل: «درد دارید؟») باشند. پرسش‌های باز، بیمار را به توضیح بیشتر و آزادانه‌تر سوق می‌دهند، درحالی‌که...

استفاده هماهنگ از پرسش و هدایت موجب می‌شود که:

- بیمار احساس کنترل، امنیت و مشارکت بیشتری داشته باشد؛
- مراقب بتواند اطلاعات مورد نیاز را به شکلی مؤثرتر به دست آورد؛
- سوءتفاهم‌ها و برداشت‌های نادرست کاهش یابد؛

- تصمیم‌گیری درمانی به صورت مشترک (shared decision-making) انجام گیرد.

## تحریف

تحریف به معنای تغییر، دستکاری یا انتقال نادقیق پیام‌ها در طول روند ارتباط است. این تحریف ممکن است عمدی یا غیرعمدی، و از سوی بیمار یا مراقب سلامت رخ دهد.

## انواع تحریف

۱. تحریف زبانی: زمانی که بیمار یا مراقب از واژه‌ها یا اصطلاحاتی استفاده می‌کند که برای طرف مقابل مبهم، نامفهوم یا چند پهلوست.
۲. تحریف ادراکی: برداشت نادرست از صحبت‌های طرف مقابل به دلیل پیش‌فرض‌های ذهنی، احساسات، باورها یا تجربه‌های قبلی.
۳. تحریف عاطفی: احساساتی مانند ترس، شرم یا اضطراب باعث می‌شوند فرد اطلاعات را پنهان کرده یا وارونه بیان کند.
۴. تحریف آگاهانه: فرد (بیمار یا مراقب) به صورت عمدی واقعیت را مخفی یا تغییر می‌دهد (مثلاً بیمار درباره مصرف سیگار دروغ می‌گوید).
۵. تحریف رسانه‌ای: اطلاعاتی که از طریق منابعی مانند اینترنت، شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها به بیمار رسیده، ممکن است تحریف‌شده یا ناقص باشند.

## علل بروز تحریف

- تفاوت فرهنگی یا زبانی؛
- سطح پایین سواد سلامت؛
- ترس از قضاوت یا برخورد داکتر؛
- استفاده از زبان تخصصی و پیچیده توسط مراقبان؛
- اطلاعات نادرست از منابع غیرعلمی.

## پیامدهای تحریف

- کاهش دقت در تشخیص؛
- بروز اشتباه در تجویز دارو یا درمان؛
- کاهش اعتماد بین بیمار و مراقب؛
- تأخیر در شروع درمان مناسب؛
- احساس ناکارآمدی در سیستم درمان.

## راهکارهای کاهش تحریف

- استفاده از زبان ساده و قابل فهم؛
- پرسیدن سؤالات باز برای درک بهتر دیدگاه بیمار؛
- تکرار و بازخورد گرفتن برای اطمینان از درک صحیح پیام؛

- ایجاد فضای امن برای ابراز آزادانه نگرانی‌ها؛
- آموزش مراقبان برای ارتباط مؤثر و همدلانه.

### نگاه بالا به پایین در ارتباطات سلامت

"نگاه بالا به پایین" به نوعی از ارتباط اشاره دارد که در آن ارائه‌دهنده خدمات سلامت (داکتر، پرستار، درمانگر و...) در جایگاه قدرت، تصمیم‌گیری و هدایت کامل ارتباط قرار دارد و بیمار در موقعیتی منفعل، تابع و کمتر مشارکتی باقی می‌ماند.

این الگو ریشه در ساختار سنتی طبی دارد، جایی که داکتر به‌عنوان تنها دارنده دانش، مسئول تشخیص، درمان و تصمیم‌گیری تلقی می‌شود و بیمار صرفاً دریافت‌کننده اطلاعات یا دستورات است.

### ویژگی‌های نگاه بالا به پایین

- داکتر بیشتر سخن می‌گوید، بیمار بیشتر گوش می‌دهد؛
- تصمیم‌گیری‌ها بدون مشارکت واقعی بیمار صورت می‌گیرد؛
- پرسش‌ها بیشتر بسته و هدایت‌شده هستند؛
- نقش بیمار در روند درمان کم‌رنگ یا نادیده گرفته می‌شود؛
- نوعی سلسله‌مراتب قدرت در رابطه وجود دارد.

## دلایل شکل‌گیری این نگاه:

- تفاوت در سطح دانش تخصصی میان مراقب و بیمار؛
- ساختار آموزشی سنتی در علوم طبی؛
- محدودیت زمان در ویزیت‌ها؛
- فرهنگ‌های اقتدارگرا؛
- ناآگاهی بیماران از حقوق خود.

## پیامدهای منفی نگاه بالا به پایین:

- کاهش اعتماد و ارتباط صمیمی میان بیمار و مراقب؛
- بی‌میلی بیمار به بیان احساسات یا علائم واقعی؛
- کاهش پایبندی به درمان (عدم پیروی از دستورات)؛
- کاهش رضایت بیمار از خدمات سلامت؛
- افزایش احتمال سوء تفاهم یا خطای درمانی.

## راه حل و رویکرد جایگزین:

رویکرد «پایین به بالا» یا «رابطه مشارکتی» که در آن:

- بیمار به‌عنوان شریک در درمان دیده می‌شود؛
- تصمیم‌ها به صورت مشارکتی (Shared Decision-Making) گرفته می‌شوند؛

- شنیدن فعال، همدلی، و گفت‌وگوی دوطرفه جایگزین اقتدار یک‌سویه می‌شود.

نگاه بالا به پایین در ارتباطات سلامت گرچه ممکن است در شرایط بحرانی مؤثر باشد، اما در مراقبت‌های مزمن، روانی و ارتباطات بلندمدت باعث افت کیفیت درمان می‌شود. جایگزینی آن با مدل مشارکتی، رضایت و نتایج درمانی را بهبود می‌بخشد.

درس ششم

این درس به ارتباط همکارانه می پردازد.

## مدل ارتباط همکارانه

مدل ارتباط همکارانه الگویی نوین در تعامل میان بیمار و مراقب سلامت است که برخلاف مدل‌های سنتی (مانند مدل بالا به پایین)، بر تعامل دوطرفه، احترام متقابل و تصمیم‌گیری مشترک تأکید دارد.

در این مدل، بیمار صرفاً گیرنده دستور نیست، بلکه شریک فعالی در روند درمان به شمار می‌رود. داکتر یا مراقب نیز نقش راهنما و تسهیل‌گر را دارد، نه فقط فرمان‌دهنده.

### ویژگی‌های مدل همکارانه:

- برابری نسبی در نقش‌ها: هر دو طرف (بیمار و مراقب) در تصمیم‌گیری مشارکت دارند.
- تبادل اطلاعات: مراقب اطلاعات علمی و طبّی را ارائه می‌دهد؛ بیمار اطلاعاتی درباره سبک زندگی، احساسات، باورها و ترجیحاتش می‌دهد.
- توافق بر درمان: تصمیم نهایی با مشارکت و رضایت دوطرف اتخاذ می‌شود.
- احترام به استقلال بیمار: بیمار حق دارد نظراتش شنیده شود و در انتخاب مسیر درمان نقش داشته باشد.

### مزایای این مدل:

- افزایش اعتماد و رضایت بیمار؛
- بهبود پایبندی به درمان (بیمار احساس مالکیت نسبت به برنامه درمانی پیدا می‌کند)؛

- کاهش خطاهای ارتباطی و درمانی؛
- تقویت تصمیم‌گیری آگاهانه؛
- مناسب برای بیماری‌های مزمن یا روانی که نیاز به تعامل مداوم دارند.

### اجزای اصلی ارتباط همکارانه:

۱. شنیدن فعال: مراقب با دقت و بدون قضاوت به بیمار گوش می‌دهد؛
۲. پرسش باز: برای درک بهتر شرایط و دیدگاه بیمار؛
۳. بازخورد دوسویه: هر دو طرف نظر و احساس خود را مطرح می‌کنند؛
۴. تصمیم‌گیری مشترک: انتخاب روش درمان بر اساس ترجیحات و شرایط بیمار.

### کاربرد در عمل:

مثلاً در بیماری دیابت، داکتر صرفاً دارو تجویز نمی‌کند، بلکه با بیمار درباره رژیم غذایی، سبک زندگی، نگرانی‌ها و توانمندی‌هایش صحبت کرده و برنامه‌ای متناسب طراحی می‌کند.

مدل ارتباط همکارانه، مدلی انسانی، اخلاقی و مؤثر در سلامت است که درمان را از حالت یک‌سویه خارج کرده و بیمار را به شریک درمان تبدیل می‌کند. این مدل نه تنها نتیجه محور است، بلکه رابطه‌ای پایدار، محترمانه و مؤثر بین بیمار و مراقب ایجاد می‌نماید.

## دیالوگ

یکی از رویکردهای برقراری همکارانه ارتباط، دیالوگ است. بنا بر تعریف ازینبرگ و گودال، دیالوگ کنش‌گری است که دو یا چند نفر در موقعیتی واحد، به صورت کامل و صمیمانه مشارکت داشته، و با شنیدن یکدیگر، معنا را در نهایت به مشارکت می‌سازند. رسیدن به چنین سطحی از دیالوگ کارآسانی نیست، حتی کسانی که قدرت و گشودگی آماده شنیدن دارند، ممکن است آن‌ها گفت‌وگو کنند تا به نتیجه‌ای مناسب برسند. «وضعیت دیالوگ» در شرایط خاصی دست می‌دهد (دوپری، ۲۰۱۷: ۵۳). این سطح از روابط، دیالوگ همکارانه یا گفت‌وگوی مشترک از قدرت توزیع‌شده در فرم گفت‌وگو، در جریان‌ها و ارزش‌های فردی شکل می‌گیرد.

گاهی ممکن است افراد نتوانند وارد دیالوگ کامل شوند. مگر فشارهای فرهنگی و اجتماعی، بیمار مانع برقراری دیالوگ یا ارتباط همکارانه می‌شود.

## تکنیک‌های کلامی

در حوزه ارتباطات سلامت (Health Communication)، تکنیک‌های کلامی نقش بسیار مهمی در تأثیرگذاری بر درک، رفتار و تصمیم‌گیری مخاطبان ایفا می‌کنند. این تکنیک‌ها مجموعه‌ای از مهارت‌ها، راهبردها و روش‌هایی هستند که از طریق زبان گفتاری و نوشتاری به کار گرفته می‌شوند تا پیام‌های مربوط به سلامت به شکلی روشن، مؤثر و متقاعدکننده به مخاطب منتقل شوند. در ادامه، تعریفی جامع و دسته‌بندی‌شده از این تکنیک‌ها ارائه می‌دهم:

تکنیک‌های کلامی به مجموعه‌ای از روش‌ها و مهارت‌های زبانی گفته می‌شود که به منظور انتقال دقیق، قابل فهم و متقاعدکننده‌ی پیام‌های مرتبط با سلامت به مخاطبان به کار می‌روند. این تکنیک‌ها به تقویت رابطه بین ارائه‌دهندگان خدمات سلامت (مثل داکتر، مشاور، یا کارشناس ارتباطات) و مخاطبان (بیمار، خانواده، جامعه) کمک می‌کنند.

### اهداف استفاده از تکنیک‌های کلامی

۱. افزایش درک پیام‌های سلامت؛
۲. افزایش اعتماد مخاطب؛
۳. تسهیل تصمیم‌گیری آگاهانه؛
۴. تغییر نگرش و رفتار ناسالم؛
۵. کاهش اضطراب، سوء تفاهم و مقاومت مخاطب.

### مهم‌ترین تکنیک‌های کلامی :

۱. سادگی و وضوح زبانی
    - استفاده از واژگان ساده، قابل فهم و قابل دسترس؛
    - اجتناب از اصطلاحات تخصصی طبی برای مخاطب عام؛
- مثال: به جای گفتن «هیپرگلیسمی»، بگوییم "قند خون شما بالاست"

۲. تکرار و بازگویی نکات کلیدی

- بازگو کردن اطلاعات مهم چند بار با فرم‌های متفاوت؛
- کمک به تثبیت اطلاعات در ذهن بیمار؛

مثال: ابتدا گفتن نکته، سپس خلاصه‌سازی در پایان گفتگو

### ۳. پرسش و پاسخ فعال (Dialogue Technique)

- پرسیدن سؤال‌های باز: "چه چیزی شما را نگران کرده؟"؛
- تشویق به بیان احساسات و باورها؛
- ایجاد فضای گفت‌وگو، نه فقط دستور دادن؛

### ۴. تکنیک بازتابی (Reflective Listening)

- تکرار یا بازنویسی گفته‌های بیمار برای نشان دادن درک؛
- مثال: بیمار می‌گوید «من از مصرف دارو خسته شدم»، داکتر پاسخ می‌دهد: «یعنی احساس می‌کنید مصرف این دارو برایتان طاقت‌فرسا شده؟»

### ۵. استفاده از استعاره‌ها و تشبیه‌های ساده

- برای توضیح مفاهیم پیچیده سلامت؛
- مثال: "بدن شما مثل ماشین است، اگر روغن‌اش را عوض نکنید، موتور می‌سوزد".

## ۶. تقویت مثبت (Positive Reinforcement)

- تأیید رفتارهای سالم با زبان مثبت؛

مثال: «خیلی خوبه که ورزش رو شروع کردید، این واقعاً به کنترل قند خون کمک می‌کنه».

## ۷. استفاده از روایت (Storytelling)

- تعریف داستان‌های واقعی یا شبیه‌سازی شده برای آموزش سلامت؛

- کمک به ایجاد هم‌ذات‌پنداری و درک بهتر پیام؛

## ۸. زبان همدلانه و حمایتگر

- استفاده از جملاتی مثل: "درک‌تان می‌کنم"، «کاملاً طبیعی‌ست که احساس نگرانی داشته

باشید"

- کاهش اضطراب بیمار و ایجاد احساس امنیت؛

## ۹. ساختاردهی پیام‌ها (Structuring Information)

- دسته‌بندی اطلاعات در قالب فهرست، مراحل، یا شماره‌گذاری؛

مثال: «سه راه برای پیشگیری از دیابت داریم

## ۱۰. ارائه انتخاب و مشارکت دادن بیمار

- دادن گزینه‌های مختلف و ایجاد احساس کنترل؛

مثال: "شما می‌خواهید درمان را با دوا شروع کنیم یا ابتدا رژیم غذایی را تغییر دهیم؟"

کاربرد تکنیک‌های کلامی در موقعیت‌های مختلف سلامت:

| موقعیت             | تکنیک‌های کلامی مناسب               |
|--------------------|-------------------------------------|
| آموزش سلامت عمومی  | سادگی، استعاره، داستان              |
| مشاوره روان‌شناسی  | همدلی، گوش دادن بازتابی، پرسش باز   |
| گفتگو داکتر-بیمار  | ساختاردهی، تقویت مثبت، مشارکت دادن  |
| کمپین‌های رسانه‌ای | تکرار پیام، استفاده از شعار و روایت |

تکنیک‌های کلامی ستون فقرات ارتباط مؤثر در حوزه سلامت هستند. این تکنیک‌ها با توجه به بافت فرهنگی، سطح سواد سلامت، و وضعیت روانی مخاطب قابل تنظیم و تطبیق‌اند. هرچه ارائه‌دهنده پیام از این تکنیک‌ها آگاه‌تر باشد، احتمال موفقیت پیام سلامت در تغییر رفتار یا افزایش آگاهی بیشتر خواهد شد.

## نمونه ای از سه قصه

### بخش اول: درد جسمی

در یک روز گرم تابستانی، یکی از بیماران به کلینیک مراجعه کرد. او از درد شدید در ناحیه کمر شکایت داشت. پس از معاینه، مشخص شد که این درد ناشی از نشستن نادرست و عدم فعالیت بدنی است. ارتباطات سلامت اینجا نقش مهمی در آموزش افراد دارد تا به درستی از بدن خود مراقبت کنند.

### بخش دوم: قصه شخصی

عتیق، یک پدر شاغل، همیشه با مشکلات سلامتی ناشی از استرس کاری مواجه بود. او متوجه شد که ارتباط با یک مشاور سلامت می‌تواند به او کمک کند تا استرس خود را مدیریت کند و زندگی بهتری داشته باشد. این تجربه نشان می‌دهد که ارتباطات سلامت می‌تواند تأثیر زیادی بر بهبود کیفیت زندگی افراد داشته باشد.

### بخش سوم: قصه احساسی

یک جوان به نام احمد، که به دلیل بیماری مزمن خود احساس تنهایی می‌کرد، با گروه‌های حمایت آنلاین ارتباط برقرار کرد. این ارتباط به او امید و انگیزه داد و احساس کرد که تنها نیست. این نمونه‌ای از نقش مهم ارتباطات سلامت در ایجاد حس تعلق و حمایت احساسی است.

## تکنیک‌های غیرکلامی

ارتباطات سلامت، پروسه‌ای است که در آن اطلاعات مرتبط با بهداشت و درمان میان ارائه‌دهندگان خدمات سلامت (داکتران، پرستاران، روانشناسان، مشاوران و ...) و گیرندگان خدمات (بیماران، خانواده‌ها، جامعه) رد و بدل می‌شود. در این میان، ارتباطات غیرکلامی نقش بسیار مهمی در درک متقابل، اعتمادسازی، انتقال پیام‌های احساسی و حتی تشخیص بیماری ایفا می‌کند.

## مفهوم ارتباطات غیرکلامی

ارتباط غیرکلامی به تمام شیوه‌های تبادل اطلاعاتی اطلاق می‌شود که بدون استفاده از واژه‌ها انجام می‌گیرد. این نوع ارتباط شامل حالات چهره، حرکات بدن، تماس چشمی، لمس، حالت بدن، فاصله‌ی فیزیکی و حتی نحوه‌ی لباس پوشیدن و آراستگی ظاهری می‌شود.

## تکنیک‌های اصلی ارتباط غیرکلامی

### ۱. تماس چشمی (Eye Contact)

تماس چشمی مناسب، نشانه‌ی توجه، همدلی و صداقت است. در محیط‌های درمانی، تماس چشمی میان داکتر و بیمار می‌تواند احساس امنیت و درک را افزایش دهد. اما تماس بیش از حد ممکن است تهدیدآمیز تلقی شود و در برخی فرهنگ‌ها نیز نشانه‌ی بی‌احترامی باشد.

## ۲. حالات چهره (Facial Expressions)

چهره‌ی انسان قادر است احساسات متنوعی مانند درد، ترس، نگرانی، امید، شادی یا آرامش را نشان دهد. درک صحیح از حالات چهره‌ی بیمار می‌تواند نشانه‌ای از درد یا اضطراب او باشد. از سوی دیگر، چهره‌ی آرام و همدلانه‌ی درمانگر می‌تواند در کاهش اضطراب بیمار مؤثر باشد.

## ۳. حرکات بدن و ژست‌ها (Gestures and Body Movement)

نحوه‌ی نشستن، ایستادن، حرکات دست و پا می‌تواند پیام‌های مهمی درباره‌ی توجه، قدرت، تسلط یا بی‌تفاوتی انتقال دهد. برای مثال، خم شدن کمی به جلو در هنگام صحبت با بیمار، نشانه‌ی علاقه و توجه است.

## ۴. لحن صدا، سرعت و بلندی آن (Paralinguistics)

اگرچه لحن صدا بخشی از کلام است، اما ویژگی‌های غیرزبانی آن مانند شدت، سرعت، مکث‌ها و زیر و بمی صدا نقش عمده‌ای در تفسیر پیام دارد. گفتاری آرام با لحن ملایم می‌تواند برای بیمار آرام‌بخش باشد.

## ۵. فاصله‌ی فیزیکی (Proxemics)

رعایت فاصله‌ی مناسب فیزیکی، به‌ویژه در موقعیت‌های بستری، بسیار اهمیت دارد.

## راهکارهای عملی برای تقویت ارتباط غیرکلامی در کادر درمان

برای اینکه کارکنان حوزه سلامت بتوانند از تکنیک‌های غیرکلامی به‌درستی بهره بگیرند، لازم است مهارت‌های زیر به طور آگاهانه و تمرین شده در رفتار آن‌ها نهادینه شود:

### ۱. آموزش مهارت‌های همدلی

همدلی فقط در واژه‌ها خلاصه نمی‌شود؛ حالت چهره‌ی، گرمی در نگاه و تماس چشمی دوستانه، نوعی اطمینان به بیمار می‌دهد که او درک شده است. تمرین درک احساسات دیگران از طریق مشاهده‌ی نشانه‌های چهره‌ای و زبانی می‌تواند کیفیت ارتباط را ارتقا دهد.

### ۲. کنترل بر لحن صدا و تنفس

در هنگام انتقال اخبار ناگوار یا اطلاعات مهم، استفاده از لحن آرام، مکث‌های متناسب، و صدای قابل اعتماد باعث می‌شود بیمار پیام را بهتر دریافت کرده و دچار شوک یا سردرگمی نشود.

## نقش تکنیک‌های غیرکلامی در موقعیت‌های خاص

الف. در ارتباط با بیماران دارای اختلالات گفتاری یا شناختی

در شرایطی مانند سکته مغزی، اوتیسم، آلزایمر یا اختلالات گفتاری، ارتباط غیرکلامی راه اصلی تبادل اطلاعات است. حالات چهره، استفاده از تصویر و اشاره می‌تواند جایگزین زبان گفتاری شود.

ب. در مواجهه با بیماران بدحال یا در حال مرگ

در لحظات حساس زندگی، بیماران ممکن است نتوانند به درستی سخن بگویند یا مفاهیم را دریافت کنند. در این موقعیت‌ها، رفتارهای غیرکلامی همچون تماس آرام دست، لبخند، حضور فیزیکی، و نگاه مهربان، تسکین روانی شدیدی فراهم می‌کند.

ج. در پروسه آموزش سلامت به جامعه

در جلسات آموزشی، رفتار تسهیل‌گر، حرکات دست هماهنگ با محتوا، ایستادن در موقعیت مناسب نسبت به مخاطبان و برقراری تماس چشمی باعث می‌شود مخاطب راحت‌تر به پیام سلامت واکنش نشان دهد.

**پیامدهای منفی ارتباط غیرکلامی ضعیف**

ایجاد بی‌اعتمادی: نگاه پراکنده، بدن بسته (مثل دست به سینه)، صدای تند ممکن است در بیمار احساس بی‌اهمیتی یا تهدید ایجاد کند.

تشخیص نادرست: نادیده گرفتن علائم غیرکلامی مثل درد در چهره یا بی‌قراری بدنی می‌تواند باعث تشخیص غلط شود.

کاهش همکاری بیمار: اگر بیمار احساس کند که شنیده نمی‌شود یا درک نمی‌شود، ممکن است توصیه‌های درمانی را دنبال نکند.

## درکل؛

ارتباط غیرکلامی ستون پنهان، ولی اساسی در ارتباطات سلامت است. این نوع ارتباط، فراتر از واژه‌ها، حامل پیام‌های احساسی، روانی و فرهنگی است که می‌تواند نتیجه‌ی درمان را دگرگون کند. آموزش و تمرین مداوم تکنیک‌های غیرکلامی باید بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام تربیت نیروی انسانی در نظام سلامت باشد.

### مصاحبه روشنگرانه (Informative Interview)

در حوزه ارتباطات سلامت، به گفت‌وگویی ساختارمند میان متخصص سلامت (مانند داکتر، پرستار یا مشاور سلامت) و بیمار یا مخاطب اطلاق می‌شود که هدف اصلی آن افزایش آگاهی، تصحیح اطلاعات نادرست، ارتقاء درک از مسائل سلامت و توانمندسازی مخاطب برای تصمیم‌گیری بهتر در مورد وضعیت سلامت خود است.

در ادامه، این مفهوم را از ابعاد مختلف به طور جامع توضیح می‌دهم:

### تعریف جامع

مصاحبه روشنگرانه در ارتباطات سلامت، شکلی از گفت‌وگو است که تمرکز آن بر ارائه اطلاعات دقیق، علمی، واضح و قابل‌فهم در مورد یک موضوع مرتبط با سلامت به مخاطب است. برخلاف مشاوره یا مصاحبه درمانی که بیشتر جنبه روانی یا حمایتی دارد، مصاحبه روشنگرانه آگاهی‌بخش است و هدف آن این است که فرد مخاطب بتواند بر اساس اطلاعات دریافتی، انتخاب‌های آگاهانه و مسئولانه انجام دهد.

## ویژگی‌های کلیدی مصاحبه روشنگرانه

۱. اطلاع‌رسانی دقیق: ارائه اطلاعات مستند و علمی درباره موضوعاتی مانند بیماری‌ها، پیشگیری، درمان، دارو، رژیم غذایی و غیره؛
۲. بی‌طرفی: مصاحبه‌گر تلاش می‌کند بدون تحمیل نظر یا فشار، اطلاعات را منتقل کند؛
۳. ساده‌سازی مفاهیم طبی: استفاده از زبان قابل فهم برای افراد غیرمتخصص؛
۴. شنودگی فعال: دریافت بازخورد از مخاطب برای اطمینان از درک درست مطالب؛
۵. پاسخ به سوالات و ابهامات: مخاطب تشویق می‌شود تا سوالات خود را مطرح کند؛
۶. شفافیت اخلاقی: رعایت اصول رازداری، احترام به حریم شخصی و حفظ کرامت بیمار.

## اهداف مصاحبه روشنگرانه

- ارتقاء سواد سلامت (Health Literacy)
- اصلاح باورهای نادرست درباره بیماری‌ها یا درمان‌ها؛
- کاهش اضطراب و ترس ناشی از ناآگاهی؛
- جلب مشارکت فعال بیماران در پروسه درمان؛
- تقویت اعتماد میان بیمار و کادر درمان؛
- حمایت از تصمیم‌گیری آگاهانه و داوطلبانه.

## مثال‌هایی از موقعیت‌های مصاحبه روشنگرانه

- داکتر به بیمار دیابتی درباره نحوه کنترل قند خون، مصرف انسولین و رژیم غذایی توضیح می‌دهد؛
- مامور بهداشت به خانواده‌ها اطلاعاتی درباره واکسیناسیون کودکان و فواید آن می‌دهد؛
- مشاور تغذیه درباره تغذیه سالم در دوران بارداری با مادران صحبت می‌کند؛
- روانشناس درباره اثرات استرس و راهکارهای مقابله با آن، اطلاعات علمی ارائه می‌کند.

## نکات کلیدی برای اجرای مؤثر مصاحبه روشنگرانه

- آمادگی قبلی و شناخت سطح سواد سلامت مخاطب؛
- استفاده از ابزارهای کمک آموزشی (بروشور، مدل)؛
- توجه به عوامل فرهنگی و زبانی مخاطب؛
- پرهیز از اصطلاحات پیچیده طبی؛
- خلاصه‌سازی اطلاعات مهم و یادآوری نکات کلیدی؛
- اطمینان از درک مطالب از طریق پرسیدن سوال‌های باز.

## تعریف «وضعیتی به نام بیماری»

"وضعیت بیماری" به حالتی اطلاق می‌شود که فرد دچار ناتوانی یا اختلالی در کارکرد طبیعی جسم یا روان خود می‌شود، و این وضعیت به نحوی تجربه، درک، بازنمایی و درباره‌اش گفتگو می‌شود که از منظر ارتباطات، بسیار قابل مطالعه است.

### جنبه‌های ارتباطی وضعیت بیماری:

#### ۱. بیماری به عنوان یک تجربه فردی-اجتماعی؛

فرد بیمار نه تنها درد جسمی را تجربه می‌کند، بلکه اضطراب، نگرانی و برچسب‌های اجتماعی نیز بر او تحمیل می‌شود. او ناچار است درباره بیماری خود با اطرافیان، داکتر، خانواده و جامعه صحبت کند یا از نگاه دیگران آن را پنهان کند.

#### ۲. نقش رسانه‌ها در بازنمایی بیماری؛

رسانه‌ها با نحوه پوشش بیماری‌ها (مثلاً سرطان، کرونا، ایدز) بر نگرش مردم، تصمیمات بهداشتی و رفتارهای درمانی تأثیر می‌گذارند. گاهی بیماری‌ها در رسانه‌ها انگ‌زده یا برعکس، عادی‌سازی می‌شوند.

#### ۳. تأثیر بر هویت و نقش اجتماعی فرد؛

فرد بیمار ممکن است نقش‌های قبلی خود (مثلاً نقش پدر، کارمند، محصل) را نتواند ایفا کند. این تغییر در نقش‌ها، نیازمند بازتعریف هویت در روند ارتباطی است.

#### ۴. زبان بیماری: (Illness Narrative) ؛

افراد معمولاً درباره بیماری خود داستان می‌سازند؛ یعنی آن را در قالب قصه‌ای برای دیگران تعریف می‌کنند. این روایت‌ها بخش مهمی از درک عمومی و شخصی از بیماری است و در درمان نیز می‌تواند نقش داشته باشد.

#### ۵. برخورد نظام سلامت با بیماری؛

در نظام طبی بی‌پایه‌ی انسانی، بیماری گاهی به شکل «شیء» دیده می‌شود و فرد به‌عنوان «مورد» نه انسان. اما در رویکردهای انسانی و ارتباط‌محور، بیمار به‌عنوان یک «انسان کامل» دیده می‌شود که احساسات، ارزش‌ها، فرهنگ و باورهای خاص خود را دارد.

درکل؛

در ارتباطات سلامت، «وضعیتی به‌نام بیماری» مفهومی است که فراتر از اختلال فیزیکی است و در واقع، شامل یک شبکه از تعاملات ارتباطی، فرهنگی، روانی و اجتماعی می‌شود. تحلیل این وضعیت به ما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از نیازهای بیماران، نقش زبان و روایت در پروسه درمان، و عملکرد نظام سلامت در جامعه پیدا کنیم.

## "دنیای زندگی، دنیای تداوی"

این عبارت بیان گر این حقیقت است که سلامت و تداوی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره انسان‌هاست. تداوی نه فقط به معنای دارو و درمان طبی، بلکه به عنوان یک پروسه انسانی، اجتماعی و ارتباطی تعریف می‌شود که ریشه در دنیای واقعی زندگی افراد دارد.

در دنیای زندگی، انسان‌ها با درد، رنج، امید، ترس، باورهای فرهنگی و تجربیات گذشته خود مواجه‌اند. بنابراین، تداوی فقط یک پاسخ فنی به بیماری نیست، بلکه یک پروسه معنامحور است که در بستر زندگی روزمره شکل می‌گیرد.

### نقش ارتباط در پیوند زندگی و تداوی

در شرایطی که بیمار با چالش سلامتی مواجه می‌شود، او نه تنها به اطلاعات نیاز دارد، بلکه به درک، همدلی و گفت‌وگو نیز نیازمند است. درمان‌گر، زمانی موفق است که وارد دنیای زندگی بیمار شود؛ باورها و ارزش‌های او را درک کند و به زبان او سخن بگوید.

دیدگاهی در این حوزه بر این باور است که اگر پیام سلامت با واقعیت‌های زندگی مردم هماهنگ نباشد، آن پیام اثربخش نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر به مردم درباره تغذیه سالم توصیه شود اما شرایط اقتصادی یا فرهنگی آنها در نظر گرفته نشود، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

## دنیای زندگی به عنوان منبع معنا

انسان‌ها از زندگی روزمره خود معنا می‌گیرند. حتی بیماری هم در دل این معناها تعریف می‌شود: پس درمان مؤثر، زمانی اتفاق می‌افتد که این معناها شناخته و محترم شمرده شوند. اگر مراقب سلامت، به این معانی بی‌اعتنا باشد، نمی‌تواند رابطه‌ای انسانی و درمان‌گرانه شکل دهد.

## تداوی، فراتر از درمان جسم

وقتی از تداوی سخن می‌گوییم، فقط منظور درمان جسم نیست، بلکه آرام‌سازی ذهن، تقویت روحیه، بازسازی امید، و ایجاد احساس امنیت نیز جزئی از آن است. این نوع تداوی، تنها زمانی ممکن می‌شود که ارتباط بین بیمار و نظام سلامت، یک ارتباط انسانی و معنادار باشد.

درکل؛

"دنیای زندگی، دنیای تداوی" به ما یادآوری می‌کند که:

برای موفقیت در درمان، باید انسان را در بستر زندگی‌اش دید، نه فقط در بستر بیمارستان.

درمان از گفت‌وگو آغاز می‌شود، از همدلی، از شنیدن داستان زندگی، از دیدن انسان در کلیت وجودی‌اش. ارتباطات سلامت، در این نگاه، یک عمل انسانی و فرهنگی است؛ پلی میان تجربه زیست انسان و دانش طبی.

## احساسات و شواهد: یک بررسی جامع

در حوزه ارتباطات سلامت، موضوع «احساسات و شواهد» به یکی از بنیادی‌ترین چالش‌ها و ضرورت‌ها در انتقال پیام‌های مؤثر سلامت مربوط می‌شود. یعنی چگونه می‌توان بین احساسات انسانی و شواهد علمی، تعادل برقرار کرد تا پیام سلامت هم قابل پذیرش باشد و هم رفتار سالم ایجاد کند.

### ۱. تعریف احساسات در ارتباطات سلامت

احساسات در این حوزه، واکنش‌های روان‌شناختی و هیجانی بیماران، مخاطبان یا عموم مردم نسبت به پیام‌های سلامت است. احساساتی مانند ترس، امید، اضطراب، خشم یا همدلی می‌توانند:

- پذیرش یا رد پیام سلامت را تعیین کنند؛
- تصمیم‌گیری‌های طبی را تسهیل یا مختل نمایند؛
- انگیزه‌ی رفتارهای پیشگیرانه یا درمانی را تقویت یا تضعیف کنند.

مثال: اگر فردی از بیماری سرطان می‌ترسد، ممکن است پیام‌های مربوط به غربال‌گری را نادیده بگیرد، حتی اگر شواهد علمی از اهمیت آن حمایت کنند.

### ۲. تعریف شواهد در ارتباطات سلامت

شواهد، اطلاعات علمی، طبی و آماری هستند که بر پایه تحقیقات معتبر ارائه می‌شوند. این‌ها شامل:

- نتایج تحقیقات علمی؛
- داده‌های اپیدمیولوژیک؛
- توصیه‌نامه‌های سازمان‌های سلامت؛
- دستورالعمل‌های درمانی و پیشگیری.

هدف از استفاده شواهد: جلب اعتماد، مشروعیت علمی، و هدایت رفتار مخاطب بر اساس اطلاعات دقیق و قابل اتکا.

۳. چالش‌ها در ترکیب احساسات و شواهد

۱. غلبه احساسات بر شواهد:

اگر پیام بیش از حد احساسی باشد، ممکن است با واکنش‌های افراطی یا ترس شدید همراه شود که به انکار یا دوری از اطلاعات علمی می‌انجامد.

۲. خشکی شواهد بدون احساس:

اگر فقط داده‌های علمی خشک ارائه شوند، پیام ممکن است برای مردم عادی غیرقابل فهم یا بی‌اهمیت تلقی شود و هیچ تغییری در رفتار ایجاد نکند.

۳. تضاد بین باور احساسی و شواهد علمی:

مثلاً فردی ممکن است به دلیل تجربه‌ی بد قبلی، با وجود شواهد علمی، به دارویی خاص بی‌اعتماد باشد.

۵. راهبردهای کاربردی برای ترکیب احساسات و شواهد

- استفاده از روایت‌های شخصی همراه با داده علمی؛
- به‌کارگیری تصاویر و ویدیوها برای انتقال احساسات مثبت؛
- تنظیم لحن پیام (نه بیش از حد ترسناک، نه بیش از حد خشک)؛
- استفاده از سخنگویان قابل اعتماد (داکتر، والد، بیمار موفق)

در کل؛

در ارتباطات سلامت، پیام‌هایی که تنها بر شواهد علمی استوار باشند، بدون در نظر گرفتن احساسات مخاطب، کمتر تأثیرگذار خواهند بود. از سوی دیگر، پیام‌هایی که تنها احساسات را تحریک کنند، ممکن است علمی نباشند یا حتی مخاطب را گمراه کنند.

درس هفتم

در این درس به موضوعات مرتبط اجتماعی - فرهنگی سلامت پرداخته می شود.

## درد؛ حواشی درد

در حوزه ارتباطات سلامت، «درد» نه تنها به عنوان یک پدیده زیستی یا فیزیولوژیک مطرح می شود، بلکه به عنوان یک تجربه انسانی پیچیده که در بافت اجتماعی، روانی و فرهنگی معنا می یابد، مورد بررسی قرار می گیرد. این دیدگاه جامع به ما امکان می دهد که درک عمیق تری از چگونگی درک، بیان و پاسخ به درد در نظام های سلامت و در میان افراد و جوامع مختلف داشته باشیم.

### ۱. تعریف درد از منظر ارتباطات سلامت

درد در این حوزه، تنها یک پیام حسی نیست؛ بلکه یک پیام ارتباطی است. زمانی که فردی درد را تجربه می کند، او با کلمات، حرکات بدن، حالات چهره یا حتی سکوت خود در حال «ارسال پیام» است. این پیام معمولاً برای جلب توجه، دریافت کمک، ابراز رنج یا حتی نشان دادن نارضایتی است. بنابراین درد بخشی از نظام انتقال معنا در تعاملات درمانی و مراقبتی به شمار می رود.

### ۲. حواشی درد: ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی

الف. بعد اجتماعی:

نحوه مواجهه با درد در بسترهای اجتماعی متفاوت است. مثلاً در برخی فرهنگ ها، ابراز درد نشانه ضعف تلقی می شود، در حالی که در جوامع دیگر ممکن است ابراز آن برای دریافت حمایت اجتماعی پذیرفته و حتی مورد انتظار باشد.

در محیط‌های درمانی، روابط میان بیمار، طبیب، پرستار و خانواده در تفسیر و مدیریت درد نقش اساسی دارد.

ب. بعد فرهنگی:

باورها، هنجارها و تجارب فرهنگی تأثیر زیادی بر ادراک و ابراز درد دارند. برای نمونه، یک بیمار از فرهنگ شرقی (کشورهای شرقی) ممکن است درد را با سکوت و تحمل پاسخ دهد، در حالی که بیمار دیگری از فرهنگ غربی (کشورهای غربی) آن را به صراحت بیان کند. از این‌رو، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت باید به تنوع فرهنگی بیماران در ارتباطات مرتبط با درد توجه داشته باشند.

ج. بعد روانی و زبانی:

زبان ابزار اصلی انتقال تجربه درد است. اما مشکل اصلی آن است که درد، تجربه‌ای است غالباً «ناقابل توصیف». بسیاری از بیماران نمی‌توانند احساس خود را به دقت بیان کنند یا واژگان کافی برای توصیف شدت، نوع یا موقعیت درد در اختیار ندارند. اینجاست که نقش مهارت‌های ارتباطی طبیب بسیار حیاتی می‌شود.

۳. نقش ارتباطات سلامت در مدیریت و درک درد

گوش‌دادن فعال توسط کارکنان سلامت، یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای شناخت نوع و شدت درد است.

پرسش‌های باز می‌توانند به بیمار کمک کنند تا احساسات، ترس‌ها و تجربه‌های مرتبط با درد را بهتر بیان کند.

زبان بدن، تماس چشمی، تن صدا می‌توانند به بیماران آرامش دهند و احساس درک‌شدن ایجاد کنند.

ارتباط بین فرهنگی مؤثر، به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت کمک می‌کند تا پاسخ‌هایی متناسب با باورها، احساسات و انتظارات بیمار داشته باشند.

#### ۴. چالش‌های ارتباطی پیرامون درد

تفاوت در ادراک میان بیمار و درمان‌گر: ممکن است طبیب درد بیمار را جدی نگیرد یا شدت آن را کمتر از واقعیت ارزیابی کند.

سوء تفاهم زبانی یا فرهنگی: بیمار نتواند تجربه خود را منتقل کند یا درمانگر زبان مشترک فرهنگی با او نداشته باشد.

ننگ اجتماعی یا ترس از قضاوت: بعضی بیماران، ممکن است از ترس قضاوت یا بی‌اعتبار شدن از بیان درد اجتناب کنند.

در کل؛

در ارتباطات سلامت، درد تنها یک احساس نیست؛ بلکه یک پیام ارتباطی، یک تجربه روان اجتماعی و یک رخداد فرهنگی است. شناخت «حواشی درد» به معنای شناخت زمینه‌هایی است که در آن

درد شکل می‌گیرد، معنا می‌یابد و منتقل می‌شود. ارتباط مؤثر، حساسیت فرهنگی و مهارت در درک غیرکلامی، کلیدهای اصلی در مواجهه با درد در سیستم‌های سلامت به‌شمار می‌روند. با این نگاه، می‌توان به تجربه انسانی درد نه به‌عنوان یک مانع، بلکه به‌عنوان دروازه‌ای برای همدلی، شناخت و مراقبت بهتر نگریست.

### تعریف جامع در چارچوب ارتباطات سلامت:

"بیماری، هویت شخصی" به معنای آن است که تجربه بیماری می‌تواند به طور چشم‌گیری درک فرد از هویت خویش را تغییر دهد و نقش‌ها، روابط اجتماعی و نحوه تعامل او با دیگران (از جمله خانواده، جامعه، و کادر درمان) را تحت تأثیر قرار دهد. در این چارچوب، ارتباطات سلامت نقشی کلیدی در چگونگی روایت بیماری، پذیرش آن و بازسازی هویت شخصی ایفا می‌کند.

### محورهای کلیدی در تحلیل این عنوان:

#### ۱. روایت بیماری: (Illness Narrative)

افراد برای معنا بخشیدن به تجربه بیماری خود، داستان‌هایی را روایت می‌کنند. این روایت‌ها بخش مهمی از هویت بیمار می‌شوند. نوع بیان درد، رنج، امید و مقاومت، درکی تازه از خود به فرد می‌دهد.

## ۲. بازتعریف خود: (Reconstruction of Self)

بسیاری از افراد پس از بیماری‌های مزمن یا بحرانی، احساس می‌کنند که «خود قبلی» را از دست داده‌اند و نیازمند بازتعریف هویت خویش هستند؛ این بازتعریف با نوع تعامل آن‌ها با محیط اجتماعی و سیستم درمانی مرتبط است.

## ۳. نقش برچسب‌گذاری اجتماعی: (Social Labeling)

در بسیاری از فرهنگ‌ها، برچسب‌هایی مانند «معلول»، «سرطانی»، «معتاد» یا «بیمار روانی» بر فرد پیوند می‌شود که هویت اجتماعی فرد را شکل می‌دهد. نحوه مدیریت این برچسب‌ها از طریق ارتباطات بین فردی و رسانه‌ای، تعیین‌کننده عزت نفس و ادراک فرد از خود است.

## ۴. هویت بیمار در سیستم درمانی:

نظام سلامت، اغلب بیماران را به عنوان «مورد طبی» یا «تشخیص» می‌بیند، نه به عنوان انسان‌های کامل با داستان و هویت. ایجاد گفت‌وگوی انسانی و شفقت‌محور بین بیمار و متخصصان سلامت، به بازسازی هویت فردی کمک می‌کند.

## ۵. نقش خانواده و جامعه در تثبیت یا تضعیف هویت بیمار:

نوع حمایت اجتماعی یا طرد و قضاوت می‌تواند سبب شود که فرد خود را قربانی ببیند یا برعکس، خود را قوی و توانمند تجربه کند.

در ارتباطات سلامت، بیماری صرفاً یک وضعیت فیزیولوژیک نیست، بلکه پروسه‌ی پیچیده‌ای است که می‌تواند هویت شخصی را دگرگون سازد. ارتباطات میان‌فردی، رسانه‌ای و نهادی نقش تعیین‌کننده‌ای در معنا یافتن این هویت جدید ایفا می‌کنند. توجه به این بُعد از بیماری، راهی برای مراقبت انسانی‌تر، اخلاقی‌تر و مؤثرتر است.

### واکنش هویتی بیمار

در حوزه ارتباطات سلامت، «واکنش هویتی بیمار» به چگونگی دریافت، درک و واکنش فرد بیمار نسبت به بیماری خود و تأثیر آن بر هویت شخصی و اجتماعی او اشاره دارد. این واکنش، یکی از عناصر مهم در فهم تجربه زیسته بیمار است و نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه برقراری ارتباط بیمار با نظام سلامت، خانواده، اجتماع و خود بیمار دارد.

### تعریف مفهومی

بیماری تنها یک پدیده فیزیولوژیک نیست، بلکه یک رخداد اجتماعی-روانی نیز به شمار می‌رود که هویت فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنگامی که فرد بیمار می‌شود، ممکن است تصویر ذهنی‌اش از خود دچار تغییر شود؛ به‌ویژه در بیماری‌های مزمن، ناتوان‌کننده یا بیماری‌هایی که با داغ اجتماعی (stigma) همراه هستند. واکنش هویتی بیمار شامل نحوه تفسیر فرد از بیماری‌اش، برداشت او از نگاه دیگران، و تلاش برای بازسازی یا حفظ هویت قبلی‌اش در مواجهه با شرایط جدید است.

## ابعاد مختلف واکنش هویتی بیمار

۱. درک از خود: بیمار ممکن است احساس کند که دیگر آن فرد سابق نیست. برای نمونه، ممکن است فردی که همیشه فعال و مستقل بوده، در پی یک بیماری جسمی، خود را ضعیف، وابسته یا ناکارآمد ببیند.

۲. ادراک اجتماعی: نگرانی از قضاوت دیگران، طرد اجتماعی، یا برچسب خوردن (مثلاً در بیماری‌های روانی، ایدز، یا اعتیاد) می‌تواند واکنش‌های دفاعی، پنهان‌سازی یا انکار را در فرد ایجاد کند.

۳. بازتعریف هویت: برخی بیماران، به‌جای فروپاشی هویتی، می‌کوشند تا معنایی تازه از خود و زندگی خود بیافرینند. آنان با پذیرش بیماری، به بازسازی هویت‌شان می‌پردازند، برای نمونه با شرکت در گروه‌های حمایتی یا با ایفای نقش فعال در روند درمان.

۴. تعامل با نظام سلامت: واکنش هویتی بیمار می‌تواند نوع تعامل او با متخصصان سلامت را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بیمارانی که هویت خود را در خطر می‌بینند، ممکن است در برابر توصیه‌های درمانی مقاومت کنند، یا از گفتگو درباره جنبه‌های حساس بیماری‌شان خودداری نمایند.

## نقش ارتباطات سلامت

در این میان، ارتباطات سلامت نقش کلیدی در مدیریت واکنش هویتی بیمار دارد. داکتران، پرستاران، مشاوران و حتی رسانه‌ها می‌توانند با به‌کارگیری شیوه‌های همدلانه، تقویت حس شایستگی در بیمار و فراهم کردن اطلاعات دقیق و انسانی، به بیمار کمک کنند تا هویت خود را بهتر بازسازی کرده و با بیماری خود سازگار شود.

به‌ویژه در ارتباطات درمانی، استفاده از زبان حمایت‌گر، احترام به کرامت انسانی بیمار، مشارکت دادن او در تصمیم‌گیری‌های درمانی، و پرهیز از نگاه تحقیرآمیز یا تنه‌آیینی (Reductionism)، همگی به کاهش تنش‌های هویتی و افزایش حس کنترل و اعتماد بیمار کمک می‌کند.

درکل؛

«واکنش هویتی بیمار» مفهومی چندبُعدی و پیچیده است که پیوند تنگاتنگی با سلامت روان، کیفیت درمان و حتی پیامدهای فیزیکی بیماری دارد. فهم این واکنش، نه‌تنها برای درمان مؤثر، بلکه برای حمایت انسانی و اخلاقی از بیماران ضروری است. ارتباطات سلامت، با نگاهی انسانی و تعامل‌محور، می‌تواند بستری برای تسکین دردهای روانی و حفظ عزت‌نفس بیمار فراهم آورد و به او کمک کند که در مسیر بیماری، هویت خود را از نو بسازد، نه آنکه آن را از دست بدهد.

#### چهار مرحله واکنش هویتی بیمار

##### ۱. مرحله شوک و انکار (Identity Shock / Denial)

در این مرحله، فرد پس از آگاهی از بیماری (به‌ویژه بیماری‌های جدی، مزمن) دچار شوک روانی می‌شود. واکنش معمول او انکار واقعیت بیماری یا بی‌اهمیت جلوه‌دادن آن است. این مرحله می‌تواند به‌صورت واکنش‌هایی مانند:

"من اشتباه شنیدم.."

"من که هیچ علامتی ندارم..."

"لابد آزمایش اشتباه شده..."

بروز یابد. در این مرحله، فرد هنوز نمی‌تواند بیماری را با تصور سابق خود از «هویت سالم» سازگار کند.

## ۲. مرحله درگیری هویتی (Identity Conflict / Chaos)

با گذشت زمان، فرد واقعیت بیماری را می‌پذیرد، اما با بحران هویتی مواجه می‌شود. او دیگر نمی‌داند "چه کسی" است: آیا هنوز همان فرد سابق است یا بیماری او را به انسانی متفاوت تبدیل کرده است؟

این مرحله اغلب با احساساتی مانند:

- خجالت، ترس، اضطراب، شرم
- احساس از دست دادن کنترل بر بدن و زندگی
- شکستن تصویر ذهنی از "خود سالم"

همراه است. این درگیری هویتی می‌تواند روابط اجتماعی، اعتماد به نفس، و حتی تمایل به درمان را تحت تأثیر قرار دهد.

## ۳. مرحله سازش هویتی (Identity Negotiation / Adaptation)

در این مرحله، فرد می‌کوشد میان هویت سابق خود و واقعیت بیماری تعادل ایجاد کند.

## مرحله چهارم: بازسازی هویت (Identity Reconstruction)

در این مرحله، بیمار نه تنها واقعیت بیماری خود را پذیرفته، بلکه آن را در قالبی جدید و مثبت در هویت خود ادغام کرده است. این بازسازی، روند خلاقانه و روانی است که بیمار طی آن:

تجربه بیماری را به بخشی از داستان زندگی اش تبدیل می کند؛

معنا و ارزش جدیدی برای خود و زندگی اش پیدا می کند؛

به جای قربانی بودن، به بازیگر فعال زندگی و درمان تبدیل می شود.

ویژگی های این مرحله:

۱. پذیرش آگاهانه بیماری:

دیگر بیماری به عنوان تهدید هویت دیده نمی شود، بلکه بخشی از «خود» جدید بیمار است.

۲. تعریف مجدد از خود:

فرد می گوید: "من فقط یک بیمار نیستم، بلکه انسانی هستم که تجربه ای خاص را از سر گذرانده ام."

"این بیماری باعث شد بیشتر به خود و زندگی ام فکر کنم."

۳. افزایش توانمندی روانی و اجتماعی:

در این مرحله، بیمار ممکن است در فعالیت های داوطلبانه، آموزشی یا حمایتی برای دیگر بیماران

نقش بگیرد. این کار باعث تقویت حس معنا و هویت جدید او می شود.

۴. بهبود تعامل با دیگران:

ارتباط با خانواده، داکتران، و جامعه از موقعیتی آسیب‌پذیر به رابطه‌ای برابرتر و مبتنی بر احترام متقابل تبدیل می‌شود.

۵. ادغام بیماری در سبک زندگی:

فرد راه‌هایی برای تطبیق زندگی روزمره با محدودیت‌های بیماری پیدا کرده و سبک جدیدی از زندگی سالم‌تر یا متعادل‌تر اتخاذ کرده است.

درکل:

مرحله بازسازی هویت، نقطه اوج رشد روانی و اجتماعی بیمار پس از تجربه بیماری است. این مرحله با حمایت عاطفی، ارتباط درمانی مؤثر و درک درست از تجربه زیست بیمار تقویت می‌شود و نقشی تعیین‌کننده در بهبود کیفیت زندگی و سازگاری درازمدت دارد. ارتباطات سلامت می‌تواند با فراهم‌آوردن فضای امن و معنادار برای گفتگو، نقش کلیدی در شکل‌گیری این هویت بازسازی‌شده ایفا کند.

درس نهم

در این درس ابتدا یک تصویر کلی برای محصلان گرامی ارائه می شود، بعد امتحان ۲۰٪ اخذ می گردد.

درس دهم

این درس به موضوع مددکاری اجتماعی ارتباط دارد.

## مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی یک رشته پوهنتونی و حرفه‌ای مبتنی بر عمل است که هدف آن ارتقاء رفاه فردی و اجتماعی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر و ایجاد عدالت اجتماعی از طریق مداخلات ساختاری و حمایتی است. این حرفه با بهره‌گیری از دانش میان‌رشته‌ای مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و علوم سیاسی، به بهبود شرایط زندگی افراد و جوامع می‌پردازد.

## تعریف مددکاری اجتماعی

بر اساس تعریف فدراسیون بین‌المللی مددکاری اجتماعی، مددکاری اجتماعی حرفه‌ای است که بر اصول عدالت اجتماعی، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوت‌ها استوار است. این حرفه با بهره‌گیری از نظریه‌های مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در مقابله با چالش‌های زندگی توانمند می‌سازد و رفاه را ارتقاء می‌دهد.

## اهداف مددکاری اجتماعی

۱. ارتقاء رفاه و بهزیستی: تلاش برای بهبود کیفیت زندگی افراد، خانواده و جوامع از طریق ارائه خدمات حمایتی و مداخلات اجتماعی؛
۲. توانمندسازی افراد و جوامع: کمک به افراد برای شناخت و بهره‌برداری از توانایی‌ها و منابع خود به منظور مقابله با مشکلات؛
۳. مشارکت در تصمیم‌گیری: تشویق افراد به مشارکت فعال در روندهای تصمیم‌گیری که بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

## اصول و ارزش‌های مددکاری اجتماعی

- حرمت مقام انسانی: احترام به کرامت و ارزش ذاتی هر فرد، صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی یا مشکلاتی که با آن مواجه است؛
- حق بهره‌مندی برابر از منابع: اعتقاد به اینکه همه افراد باید دسترسی برابر به منابع و خدمات اجتماعی - سلامتی داشته باشند؛
- مسئولیت فردی و اجتماعی: تشویق افراد به پذیرش مسئولیت در قبال خود و جامعه.

## سطوح فعالیت مددکاری اجتماعی

۱. سطح خرد (Micro) : مداخلات فردی و خانوادگی، مانند مشاوره، حمایت روانی و برنامه‌ریزی درمانی؛
۲. سطح میانه (Mezzo) : کار با گروه‌ها و جوامع، مانند گروه‌های حمایتی، مدارس و سازمان‌های محلی؛
۳. سطح کلان (Macro) : مداخلات در سطح برنامه‌ریزی اجتماعی و اصلاح ساختارهای اجتماعی.

## درس یازدهم

این درس، اختصاص به کار عملی دارد، لذا در این درس موضوعات به صورت تیوریک بحث نمی‌شود.

## درس دوازدهم

در این درس مساله این است که چگونه اینترنت در خدمت سلامتی قرار گرفته است؛ از جمله، محصلان مطالبی را در مورد خدمات آنلاین - سلامتی را خواهند خواند.

## رابطه سلامت و فناوری

در قرن بیست و یکم، فناوری به یکی از ارکان اصلی تحول در حوزه سلامت تبدیل شده است. این تحول، از ابزارهای تشخیصی پیشرفته گرفته تا نرم افزارهای مدیریت سلامت، نه تنها کیفیت خدمات درمانی را ارتقاء داده، بلکه دسترسی به آن‌ها را نیز به طرز چشمگیری بهبود بخشیده است. سلامت و فناوری اکنون در پیوندی ناگسستنی به سر می‌برند و به عنوان مکمل یکدیگر، مسیر مراقبت‌های سلامت را متحول ساخته‌اند (WHO, 2021).

### ۱. تکنالوژی اطلاعات سلامت

تکنالوژی اطلاعات سلامت شامل مجموعه‌ای از سیستم‌ها و نرم افزارهایی است که برای ذخیره، تحلیل و اشتراک گذاری اطلاعات سلامت به کار می‌روند.

### ۲. سلامت همراه

سلامت همراه به استفاده از تلفن‌های هوشمند، اپلیکیشن‌ها، و پوشیدنی‌های دیجیتال در مراقبت از سلامت اطلاق می‌شود.

- اپلیکیشن‌هایی برای پایش دیابت، فشار خون، سلامت روان و مدیریت دارو توسعه یافته‌اند.
- دستبندهای سلامت و ساعت‌های هوشمند می‌توانند ضربان قلب، خواب، کالری مصرفی و میزان فعالیت بدنی را ثبت کنند (WHO, 2018).

### ۳. هوش مصنوعی در سلامت (AI in Healthcare)

هوش مصنوعی در حال تحول روندهای تشخیص و درمان است:

-تحلیل تصاویر طبی (مانند MRI و سی تی اسکن) با دقتی بالا.

-استفاده در ربات‌های جراحی و سیستم‌های مراقبت خانگی.

مثال: الگوریتم‌های گوگل موفق به تشخیص دیابت از طریق اسکن چشم شده‌اند (Poplin et al.,

۲۰۱۸)

### ۴. چاپ سه بعدی

این فناوری در حوزه سلامت کاربردهای زیر را دارد:

-تولید مدل‌های آناتومیک برای تمرین جراحی

-تولید داروهای سفارشی با دوز خاص

### ۵. اینترنت اشیاء طبی (IoMT)

IoMT شامل دستگاه‌های متصل به اینترنت است که داده‌های زیستی بیمار را در زمان واقعی

جمع‌آوری و به مراکز درمانی منتقل می‌کنند؛

-دستگاه‌های کنترل گلوکز، فشار خون یا ضربان قلب؛

-دستگاه‌های هشداردهنده برای سالمندان یا بیماران مزمن؛

## ۶. چالش‌ها و نگرانی‌ها

با وجود مزایا، فناوری سلامت با چالش‌هایی همراه است:

-حریم خصوصی داده‌های بیمار ؛

-هزینه بالای تجهیزات ؛

- عدم دسترسی برابر در مناطق دور.

فناوری نقشی اساسی در بهبود دسترسی، کیفیت، و کارآمدی خدمات سلامت ایفا کرده است. با این حال، بهره‌برداری موفق از آن نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، آموزش و رعایت اصول اخلاقی در حفظ اطلاعات بیماران است. آینده سلامت وابسته به هم‌گرایی بیشتر با فناوری خواهد بود.

درس سیزدهم

این درس در مورد مدیریت امور کلان سلامت می پردازد و نقش ارتباطات سلامت را در سطح کلان بحث می کند.

## نقش ارتباطات سلامت در مدیریت کلان سلامت عمومی با تأکید بر بازاریابی اجتماعی و روابط

### عمومی

مدیریت سلامت عمومی، به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در سطح ملی یا منطقه‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن بهبود سلامت مردم از طریق سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و آموزش است. در این روند، ارتباطات سلامت نقش کلیدی در انتقال مؤثر اطلاعات، ایجاد تغییر رفتار و جلب حمایت عمومی دارد. به‌ویژه در سطح کلان، ابزارهایی مانند بازاریابی اجتماعی و روابط عمومی سلامت به کمک سیاست‌گذاران می‌آیند تا سلامت عمومی به‌گونه‌ای اثربخش مدیریت شود (Thomas et al., ۲۰۱۹).

### ۱. مدیریت کلان سلامت عمومی و ضرورت ارتباطات

مدیریت کلان سلامت شامل تعیین اولویت‌های ملی، سیاست‌گذاری، کنترل بیماری‌های واگیر و غیر واگیر، آمادگی در برابر بحران‌ها و ارتقاء سلامت است. در همه این حوزه‌ها، موفقیت وابسته به چگونگی ارتباط‌گیری مؤثر با مردم، نهادها و رسانه‌هاست. برای مثال:

- در واکسیناسیون عمومی، اطلاع‌رسانی صحیح نقش کلیدی دارد.
- در بحران‌هایی چون کرونا، ارتباطات سلامت، ابزار مدیریت افکار عمومی و پیشگیری از شایعات شد (WHO, 2020).

## ۲. بازاریابی اجتماعی در سلامت عمومی

بازاریابی اجتماعی، کاربرد اصول بازاریابی تجاری برای تغییر رفتارهای مضر و ارتقاء رفتارهای سلامت محور است. تفاوت آن با تبلیغات سنتی در آن است که تمرکز بر منفعت عمومی دارد، نه سود اقتصادی.

### عناصر کلیدی بازاریابی اجتماعی:

- شناخت مخاطب هدف ؛
- پیام سلامت قابل فهم و متناسب با فرهنگ؛
- کانال‌های مؤثر ارتباطی (رادیو، شبکه‌های اجتماعی، پوستر و...)
- تغییر رفتار (مثل کاهش مصرف دخانیات یا ترویج ورزش).

## ۳. نقش روابط عمومی سلامت

روابط عمومی سلامت شامل مجموعه اقدامات ارتباطی برای شکل‌دهی افکار عمومی، جلب حمایت اجتماعی و تقویت اعتبار نهادهای سلامت است. در سطح کلان، این حوزه شامل:

- سخنگویان رسمی سلامت (مانند وزارت صحت) ؛
- مدیریت بحران ارتباطی (در اپیدمی‌ها یا کمبود دوا)؛
- تعامل با رسانه‌ها و خبرنگاران سلامت؛
- افزایش اعتماد عمومی به تصمیمات کلان.

روابط عمومی به تقویت شفافیت، پاسخ‌گویی و افزایش مشارکت مردمی در طرح‌های سلامت کمک می‌کند (Bernhardt, 2004).

## درکل؛

ارتباطات سلامت در مدیریت کلان سلامت عمومی، صرفاً ابزار تبلیغاتی نیست، بلکه ابزاری استراتژیک برای توانمندسازی جوامع، افزایش اثربخشی سیاست‌های سلامت و مدیریت افکار عمومی. بهره‌گیری مؤثر از بازاریابی اجتماعی و روابط عمومی می‌تواند مسیر تحقق اهداف سلامت جمعی را هموار سازد.

## درس چهاردهم

این درس در مورد تصویر سلامت در رسانه‌ها بحث می‌کند.

هدف این درس، آن است که محصلان بدانند که تا حدی مفاهیم سلامت و بیماری برآمده از فعالیت های رسانه‌ای اند.

## تصویر سلامت در رسانه‌ها (تحلیل نقش و بازنمایی موضوعات سلامت در رسانه‌های جمعی)

رسانه‌ها امروزه از مهم‌ترین ابزارهای شکل‌دهنده به افکار عمومی و سبک زندگی جوامع هستند. موضوع سلامت به عنوان یکی از مسائل حیاتی بشر، در رسانه‌ها بازنمایی گسترده‌ای دارد. این بازنمایی نه تنها آگاهی عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند بر رفتارهای فردی، تصمیمات طبی، و حتی سیاست‌های کلان سلامت اثر بگذارد (Seale, 2003). این فصل به بررسی تصویر سلامت در رسانه‌ها، نقش رسانه‌های سنتی و نوین، تأثیر مثبت و منفی آن‌ها و اهمیت سواد رسانه‌ای در تحلیل این بازنمایی‌ها می‌پردازد.

### ۱. رسانه به عنوان منبع آگاهی سلامت

مطالعات نشان می‌دهد که بسیاری از افراد، اطلاعات سلامت خود را نه از داکتر، بلکه از تلویزیون، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به دست می‌آورند (Viswanath & Emmons, 2006). رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره بیماری‌ها، سبک زندگی سالم، رژیم غذایی و مراقبت‌های بهداشتی نقش مهمی دارند.

### ۲. بازنمایی سلامت در رسانه‌های سنتی

#### الف) تلویزیون و رادیو

تلویزیون با برنامه‌های سلامت‌محور، سریال‌ها و تبلیغات دارویی، الگوی سلامت را در ذهن مخاطب شکل می‌دهد. گاهی این بازنمایی‌ها علمی و مفید، و گاهی همراه با اغراق یا تجاری‌سازی هستند (Clarke, 2011).

ب) مطبوعات

روزنامه‌ها و مجلات طبی با ارائه تحلیل‌ها، گزارش‌های میدانی و مصاحبه با متخصصان نقش برجسته‌ای در آموزش عمومی دارند، ولی گاه به دلیل جنجال‌سازی خبری، از دقت علمی فاصله می‌گیرند.

۳. سلامت در رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی

با گسترش فضای مجازی، کاربران با حجم انبوهی از اطلاعات سلامت مواجه اند.

- پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و انستاگرام پر از محتوای مربوط به سلامت هستند، اما همیشه معتبر نیستند (Ventola, 2014).

- اخبار جعلی یا توصیه‌های طبی غلط ممکن است مخاطبان را به خطر بیندازد.

۴. تأثیر رسانه‌ها بر رفتار و نگرش سلامت

رسانه‌ها می‌توانند:

- ترس یا آگاهی نسبت به بیماری‌ها را افزایش دهند (مثلاً در بحران کرونا)؛
- در پیشگیری یا دامن زدن به انگ اجتماعی نقش داشته باشند (مثل بیماری ایدز)؛
- نگرش نسبت به واکسیناسیون، چاقی، سلامت روان و مصرف دارو را تغییر دهند (Hilton et al., 2010).

## ۵. چالش‌ها و فرصت‌ها

چالش‌ها:

- انتشار اطلاعات نادرست و غیرعلمی؛
- تجاری‌سازی سلامت و تبلیغ درمان‌های بی‌اساس.

فرصت‌ها:

- افزایش سواد سلامت عمومی؛
- تقویت رفتارهای پیشگیرانه؛
- اطلاع‌رسانی سریع در بحران‌های سلامت (مانند پاندمی‌ها).

## ۶. اهمیت سواد رسانه‌ای سلامت

سواد رسانه‌ای به مخاطب کمک می‌کند تا:

- اطلاعات درست را از نادرست تشخیص دهد؛
- پیام‌های سلامت را به صورت انتقادی تحلیل کند (Nutbeam, 2000) ؛
- نظام‌های سلامت باید آموزش سواد رسانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.

در کل؛

سلامت به عنوان یک حوزه حیاتی زندگی انسان‌ها در رسانه‌ها حضوری پر رنگ دارد. با وجود فرصت‌های بی‌نظیر اطلاع‌رسانی، چالش‌هایی نظیر انتشار اطلاعات نادرست یا اغراق در بازنمایی‌ها

نیز وجود دارد. تقویت سواد رسانه‌ای در کنار نظارت حرفه‌ای بر تولید محتوای سلامت در رسانه‌ها، می‌تواند مسیر رسیدن به جامعه‌ای آگاه و سالم را هموار سازد.

درس پانزدهم

این درس به مبارزه برای سلامت عمومی اختصاص داده شده است.

هدف از ارائه این درس، آن است که محصلان شیوه‌های مبارزه برای سلامت عمومی را بیاموزند.

## مبارزه برای سلامت عمومی

### رویکردها، اهداف و ابزارهای عملی در مسیر تأمین سلامت جمعی

سلامت عمومی یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوامع انسانی است. با این حال، دستیابی به سلامت عادلانه و پایدار، همواره نیازمند مبارزه‌ای ساختاری، فرهنگی و ارتباطی در برابر عوامل بیماری‌زا، نابرابری‌های طبی و بی‌عدالتی‌های اجتماعی است (Baum, ۲۰۱۶).

#### ۱. مفهوم مبارزه در سلامت عمومی

مبارزه در این حوزه به معنای فعالیت‌های آگاهانه، سازمان‌یافته و پیوسته برای:

- رفع موانع ساختاری سلامت (فقر، آلودگی محیطی)؛
- پیشبرد آگاهی عمومی درباره مسائل سلامت؛
- تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های صحی.

این مبارزه گاهی ماهیت اجتماعی دارد (مانند کمپین‌های ضد دخانیات) و گاهی فرهنگی (مانند مبارزه با انگ بیماری‌ها) (Freudenberg, 2014).

#### ۲. اهداف مبارزه در سلامت عمومی

- برقراری برابری در دسترسی به خدمات صحی؛
- کاهش عوامل خطر ساز جمعیتی؛

- توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر؛
- افزایش سواد سلامت عمومی؛
- پیشگیری از بیماری‌ها با رویکرد اجتماعی و مشارکتی.

### ۳. شیوه‌های مبارزه برای سلامت عمومی

الف) کمپین‌های اجتماعی سلامت؛

استفاده از رسانه، و چهره‌های تأثیرگذار برای آگاه‌سازی و تغییر رفتار مردم.

نمونه: کمپین جهانی ایدز، واکسیناسیون کرونا (Wallack et al., 1993).

ب) تحرکات مردمی و اجتماع‌محور

تشکیل گروه‌های محلی برای نظارت بر خدمات بهداشتی، محیط زیست سالم و ارتقاء سلامت محله‌ها.

ج) مبارزه علمی و پژوهشی

تولید دانش بومی و کاربردی درباره بیماری‌ها، رفتارهای پرخطر و نابرابری‌های سلامت.

تحقیقات میدانی می‌توانند ابزار تصمیم‌سازی باشند (Green & Kreuter, 2005).

#### ۴. نقش ارتباطات سلامت در این مبارزه

ارتباطات سلامت ابزار کلیدی در مبارزه برای سلامت عمومی است، زیرا:

- باعث افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به مسائل سلامت می‌شود؛
- اطلاعات را قابل فهم و انگیزاننده ارائه می‌دهد؛
- مشارکت مردمی را از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های محلی تقویت می‌کن (Rimal & Lapinski, 2009).

- بی‌بی‌سی. (۱۳۸۸). میزان پذیرش طب سنتی در میان مردم افغانستان. دریافت‌شده در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸.
- کاکر، ف. (۱۳۸۸). طبیبان یونانی و گیاهان دارویی، روش سنتی دارو و درمان، مصاحبه با صفی الله امین زاده. تاریخ بازیافت ۳۰/۱۰/۱۳۹۸

## Source

- Buntin, M. B., Burke, M. F., Hoaglin, M. C., & Blumenthal, D. (2011). The benefits of health information technology: A review of the recent literature shows predominantly positive results. *Health Affairs*, 30(3), 464-471.
- Freudenberg, N. (2014). *Lethal but Legal: Corporations, Consumption, and Protecting Public Health*. Oxford University Press.
- Rimal, R. N., & Lapinski, M. K. (2009). Why health communication is important in public health. *Bulletin of the World Health Organization*, 87(4), 247–247.
- Wallack, L., Dorfman, L., Jernigan, D., & Themba, M. (1993). *Media Advocacy and Public Health: Power for Prevention*. Sage Publications.
- World Health Organization (WHO). (2013). Advocacy, communication and social mobilization for TB control: A guide to developing knowledge, attitude and practice surveys.
- World Health Organization. (2021). Global strategy on digital health 2020–2025.
- WHO. (2018). mHealth: New horizons for health through mobile technologies.
- Higgins-Steele, A. (n.d.). Towards universal health coverage and sustainable financing in Afghanistan: Progress and challenges. Retrieved in 22.10.2019 via:
- Mehta, N., & Pandit, A. (2018). Concurrence of big data analytics and healthcare: A systematic review. *International Journal of Medical Informatics*, 114, 57–65.
- Seale, C. (2003). Health and media: An overview. *Sociology of Health & Illness*, 25(6), 513–531.

- Ventola, C. L. (2014). Social media and health care professionals: Benefits, risks, and best practices. *Pharmacy and Therapeutics*, 39(7), 491–520.
- Viswanath, K., & Emmons, K. M. (2006). Message effects and social determinants of health: Its application to cancer disparities. *Journal of Communication*, 56(s1), S238–S264.
- Neale, A., & Abu Duhou, J. (2007). Health services: Knowledge, use and satisfaction of Afghan, Iranian and Iraqi settlers in Australia. In *Diversity in health and social care*. Retrieved on 21.10.2019 via:
- Neale, A. (2019). Afghanistan Multidimensional Poverty Index 2016–2017: Report and Analysis. Retrieved on 21.10.2019 via:
- Poplin, R., Varadarajan, A. V., Blumer, K., Liu, Y., McConnell, M. V., Corrado, G. S., & Peng, L. (2018). Prediction of cardiovascular risk factors from retinal fundus photographs via deep learning. *Nature Biomedical Engineering*, 2(3), 158–164.
- Wikipedia. Social work.
- Wikipedia. Clinical social work.